Perfil V3 · código por código

# Enfermedades Infecciosas

Los 72 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Enfermedades Infecciosas, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

## Situaciones clínicas 28 códigos

### 1.04.1.001 Adenitis, adenoflegmón

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Adenitis cervical aguda: ganglio unilateral doloroso, caliente y eritematoso con fiebre, típico en preescolares; agentes habituales S. aureus y S. pyogenes, a menudo tras impétigo o faringitis.
- Adenoflegmón: adenitis que se abscede; fluctuación central al examen. La ecografía cervical confirma la colección cuando hay duda.
- Adenitis sin fluctuación: antibiótico oral antiestafilocócico (cefadroxilo o flucloxacilina) por 10 días, analgesia y control a las 48–72 h.
- Con fluctuación: drenaje de la colección más antibiótico antiestafilocócico; enviar el pus a Gram y cultivo.
- Seguimiento: control hasta la resolución; biopsia solo si la adenopatía persiste, es dura, indolora o hay síntomas B (descartar linfoma o TBC ganglionar fría que fistuliza).

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 3 años presenta aumento de volumen cervical derecho de 4 días, doloroso, con fiebre de 38,5 °C. Al examen hay un ganglio submandibular de 3 cm, eritematoso, caliente y fluctuante al centro. Tuvo un impétigo facial reciente. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**
> **A)** Observación y control en 1 mes
> **B)** PPD y tratamiento antituberculoso
> **C)** Biopsia excisional para descartar linfoma
> **D)** Drenaje del adenoflegmón y antibiótico con cobertura antiestafilocócica
> **E)** Antiviral oral
> Respuesta D. La adenitis cervical aguda unilateral con signos inflamatorios en un preescolar se debe en general a S. aureus o S. pyogenes, a menudo tras impétigo o faringitis. Con fluctuación (adenoflegmón) se requiere drenaje más antibiótico antiestafilocócico (ej. cefadroxilo o flucloxacilina). La biopsia se reserva para adenopatías persistentes, duras, indoloras o con síntomas B.

### 1.04.1.003 Ántrax

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.6 Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Ántrax o carbunco (Bacillus anthracis, bacilo Gram positivo esporulado): exposición ocupacional a ganado, cueros, lana o huesos; la forma cutánea es el 95 % de los casos.
- Sospecha: pápula pruriginosa que pasa a vesícula y luego a escara negra central seca, con corona de vesículas y edema gelatinoso extenso; característicamente indolora y sin pus.
- Diferencial: aracnoidismo cutáneo y tularemia (muy dolorosos), ectima gangrenoso (neutropénicos), celulitis (dolorosa, sin escara). Forma inhalatoria: cuadro gripal que evoluciona a disnea, shock y mediastino ensanchado.
- Inicial: Gram del líquido vesicular (bacilos Gram positivos en caña de bambú), PCR en el ISP y notificación inmediata a la SEREMI; ciprofloxacino 500 mg c/12 h oral (alternativa doxiciclina 100 mg c/12 h). Nunca desbridar la escara.
- Formas sistémicas o inhalatorias: ciprofloxacino + clindamicina + meropenem EV. Seguimiento: derivar a infectología.

**PREGUNTAS (3)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 52 años, curtidor de cueros y lanares en una estancia rural, con una lesión en el antebrazo derecho de 5 días, que partió como una "picadura" que no dolía. Presenta una placa ulcerada de 2 cm con escara negruzca seca, rodeada de vesículas serosas y un extenso edema duro de todo el antebrazo. Es indolora y sin exudado purulento. Afebril, en buenas condiciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Aracnoidismo cutáneo necrótico
**B)** Carbunco cutáneo
**C)** Ectima gangrenoso
**D)** Celulitis por Staphylococcus aureus
**E)** Tularemia ulceroglandular

Respuesta B. Exposición ocupacional a cueros y lana + escara negra seca con corona de vesículas y edema extenso, indolora y sin pus: carbunco cutáneo por B. anthracis. El aracnoidismo y la tularemia son muy dolorosos; el ectima gangrenoso ocurre en neutropénicos; la celulitis es dolorosa y sin escara. Conducta: Gram y cultivo/PCR del líquido vesicular, notificación inmediata y ciprofloxacino, sin desbridar.

**Pregunta de práctica**

Un trabajador de una fábrica procesadora de cueros importados consulta por una lesión en el dorso de la mano izquierda de 4 días de evolución. Al examen se observa una escara negruzca central de consistencia dura, rodeada por vesículas con líquido claro y un marcado edema indurado en toda la mano, sin dolor a la palpación ni secreción purulenta. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

**A)** Ciprofloxacino oral
**B)** Cefazolina endovenosa
**C)** Flucloxacilina oral
**D)** Aciclovir tópico
**E)** Corticoides sistémicos a dosis altas

Respuesta A. Escara necrótica negruzca indolora con vesículas satélites y edema masivo en un trabajador expuesto a cueros: carbunco cutáneo. El tratamiento de elección es ciprofloxacino oral (500 mg cada 12 h) o, alternativamente, doxiciclina.

**Pregunta de práctica**

¿Cuál de las siguientes conductas está formalmente CONTRAINDICADA en el manejo de una lesión cutánea sospechosa de carbunco (ántrax) por Bacillus anthracis? **Seleccione la conducta contraindicada.**

**A)** Toma de frotis de líquido vesicular para tinción de Gram
**B)** Desbridamiento y resección quirúrgica amplia de la escara necrótica
**C)** Notificación obligatoria inmediata a la autoridad sanitaria
**D)** Inicio precoz de tratamiento con quinolonas
**E)** Aislamiento de contacto del paciente con la lesión cubierta

Respuesta B. El desbridamiento, curetaje o escisión de la escara está contraindicado: la manipulación rompe la barrera tisular y favorece el paso de bacterias y toxinas a la sangre, con bacteriemia, shock tóxico y muerte.

## 1.04.1.004 Brucelosis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

### QUÉ HAY QUE SABER

- Brucelosis (B. melitensis, cocobacilo Gram negativo intracelular): consumo de leche o queso de cabra sin pasteurizar o contacto ocupacional con ganado, fetos y placentas (veterinarios, matarifes).
- Sospecha: fiebre ondulante vespertina prolongada, sudoración profusa con olor a paja húmeda, astenia intensa, artralgias y hepatoesplenomegalia.
- Complicación focal más frecuente: osteoarticular (sacroileítis, espondilodiscitis); pensar en ella ante lumbago o dolor glúteo en un paciente febril.
- Confirmación: Rosa de Bengala como tamizaje y aglutinación en tubo; hemocultivo o mielocultivo en medio bifásico de Ruiz-Castañeda con incubación prolongada.
- Tratamiento: doxiciclina 100 mg c/12 h + rifampicina 600–900 mg/día por 6 semanas (alternativa: doxiciclina 6 semanas + gentamicina las 2 primeras); la monoterapia o los cursos cortos recaen. Seguimiento: derivar a infectología.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 6**

Veterinario expuesto a ganado, con dolor articular. Artrocentesis con PMN 70%. **¿Cuál es el agente o diagnóstico más probable?**

**A)** Brucelosis
**B)** Fiebre Q
**C)** Staphylococcus aureus
**D)** Streptococcus pneumoniae
**E)** Escherichia coli

Respuesta A. El nexo ocupacional (veterinario con ganado) más compromiso articular apunta a brucelosis, cuya complicación focal más frecuente es osteoarticular (sacroileítis, espondilodiscitis, artritis).

**Pregunta de práctica**

Hombre de 42 años, criador de cabras en la precordillera de Coquimbo, con 5 semanas de fiebre vespertina hasta 38,8 °C, calofríos, astenia y sudoración nocturna profusa. Hace 10 días presenta dolor lumbar bajo que se irradia al glúteo derecho. Hepatomegalia sensible y dolor a la maniobra de Fabere derecha. Consume leche y queso de cabra artesanal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Ciprofloxacino oral en monoterapia por 14 días
**B)** Doxiciclina 100 mg c/12 h + rifampicina 600–900 mg/día por 6 semanas
**C)** Ceftriaxona 2 g/día EV por 7 días
**D)** Penicilina G sódica EV por 7 días
**E)** Azitromicina 1 g/día oral por 7 días

Respuesta B. Lácteos caprinos no pasteurizados + fiebre ondulante con sudoración + sacroileítis: brucelosis por B. melitensis. Se confirma con Rosa de Bengala y aglutinación o hemocultivo en Ruiz-Castañeda, y se trata con biterapia prolongada (doxiciclina + rifampicina 6 semanas) para evitar recaídas. La monoterapia corta recae; ceftriaxona y azitromicina son de la tifoidea; la penicilina, de la leptospirosis.

## 1.04.1.005 Candidiasis oral y esofágica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

### QUÉ HAY QUE SABER

- Candidiasis oral (muguet): placas blanquecinas que se desprenden con el bajalenguas; en adultos sin causa evidente obliga a buscar VIH, diabetes, corticoides inhalados o antibióticos recientes.
- Candidiasis esofágica: muguet más odinofagia o disfagia en inmunosuprimido (VIH con CD4 <200); es enfermedad definitoria de SIDA.
- Oral leve: nistatina tópica (suspensión en enjuagues) o clotrimazol; no sirve para la forma esofágica.
- Esofágica: tratamiento empírico con fluconazol oral por 14–21 días, sin endoscopía previa.
- Si no mejora en pocos días: endoscopía con biopsia para buscar CMV o herpes. Seguimiento: derivar a infectología para estudio y manejo de la inmunosupresión de base (TARV).

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 34 años con VIH, CD4 de 90 células/mm³ y sin terapia antirretroviral, consulta por odinofagia y disfagia de 1 semana. Al examen tiene placas blanquecinas en la mucosa oral que se desprenden con un bajalenguas. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Nistatina tópica
**B)** Endoscopía con biopsia antes de cualquier tratamiento
**C)** Aciclovir endovenoso
**D)** Ganciclovir
**E)** Fluconazol oral

Respuesta E. Muguet más odinofagia en un paciente con VIH y CD4 bajo 200 es, con alta probabilidad, candidiasis esofágica. Se trata empíricamente con fluconazol oral por 14 a 21 días; la endoscopía se reserva si no mejora en pocos días, para buscar CMV o herpes. La nistatina tópica solo sirve en la candidiasis oral leve.

## 1.04.1.006 Celulitis bacteriana

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Celulitis: infección de dermis profunda y subcutáneo por S. aureus y S. pyogenes; eritema, calor y edema de bordes difusos, de instalación en 24–48 h. Buscar la puerta de entrada (tinea pedis interdigital, úlcera, herida, picadura).
- Erisipela: dermis superficial, S. pyogenes en >90 %; placa rojo brillante de bordes netos y sobreelevados, inicio brusco con fiebre alta y calofríos; el linfedema predispone.
- Leve: marcar el borde con lápiz y cefadroxilo 500 mg c/12 h, cefalexina 500 mg c/6 h o flucloxacilina 500 mg c/8 h por 7–10 días; alergia, clindamicina 300 mg c/8 h; sospecha de SAMR comunitario, cotrimoxazol forte c/12 h. La amoxicilina no cubre bien al estafilococo.
- Hospitalizar y pasar a cefazolina 1 g c/8 h EV o cloxacilina si hay toxicidad sistémica o sepsis, progresión a 48 h pese a tratamiento oral, comorbilidad descompensada (diabetes, cirrosis, inmunosupresión) o celulitis facial.
- Descartar fascitis necrotizante (dolor desproporcionado, bulas, crepitación, shock). Seguimiento: control a las 24–48 h, tratar la puerta de entrada y elevar la extremidad.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 58 años, diabético, con 3 días de eritema caliente y doloroso, de bordes difusos, en la pierna izquierda, que se extiende desde una fisura interdigital. T° 38,8 °C, FC 108 por minuto, PA 125/75 mmHg. Sin crepitación ni dolor desproporcionado; la ecografía no muestra colecciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Cefadroxilo oral y control ambulatorio en 48 horas
**B)** Aciclovir oral
**C)** Desbridamiento quirúrgico de urgencia
**D)** Mupirocina tópica
**E)** Hospitalizar y tratar con cefazolina endovenosa, además de manejar la puerta de entrada

Respuesta E. Celulitis con compromiso sistémico, fiebre y taquicardia, en un diabético requiere hospitalización y antibiótico endovenoso contra estreptococo y estafilococo, como cefazolina; además se trata la puerta de entrada, el intertrigo. El cefadroxilo oral sirve para la celulitis leve sin toxicidad. El desbridamiento se reserva para la fasceítis necrotizante.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 106 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Us- ted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más ade- cuado?

**A)** Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
**B)** Curaciones con povidona yodada
**C)** Mupirocina tópica
**D)** Amoxicilina oral por 7 días
**E)** Cefadroxilo oral por 7 días

Respuesta E. Una zona eritematosa de 10 cm alrededor de una herida abrasiva infectada con bordes parcialmente definidos corresponde a una celulitis o erisipela no purulenta, que se trata con un antibiótico oral con cobertura para estreptococo y estafilococo, como cefadroxilo por 7 días. La amoxicilina sola no cubre bien a estafilococos productores de penicilinasa, y las curaciones o la mupirocina tópica no bas

## 1.04.1.007 Cólera

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Cólera (V. cholerae O1/O139): agua o mariscos contaminados; la toxina activa la adenilato ciclasa y abre el CFTR, causando diarrea secretora.
- Sospecha: diarrea acuosa profusa en «agua de arroz», sin sangre, sin fiebre ni dolor importante, con vómitos; pérdidas de hasta 1 L/h y shock hipovolémico en horas. Pensarlo en viajeros desde zona endémica.
- Prioridad absoluta: rehidratación. SRO OMS si tolera vía oral; Ringer lactato EV enérgico si hay shock o deshidratación severa.
- Antibiótico en cuadros moderados a severos (solo acorta la diarrea): doxiciclina 300 mg dosis única; niños y embarazadas, azitromicina dosis única. No usar loperamida.

- Enfermedad de notificación obligatoria inmediata. Seguimiento: derivar y hospitalizar para manejo de volumen y estudio con coprocultivo.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 35 años regresó hace 2 días de Haití. Presenta diarrea acuosa muy abundante, con aspecto de agua de arroz, sin fiebre ni dolor importante, y vómitos. PA 80/50 mmHg, FC 125 por minuto, mucosas secas y signo del pliegue positivo. **¿Cuál es la medida más importante del tratamiento?**
> **A)** Esperar el coprocultivo antes de iniciar el tratamiento
> **B)** Loperamida para frenar las pérdidas
> **C)** Ciprofloxacino como única medida
> **D)** Rehidratación endovenosa enérgica con Ringer lactato
> **E)** Vancomicina oral
> Respuesta D. Diarrea acuosa profusa tipo agua de arroz después de estar en zona endémica sugiere cólera. Lo que salva la vida es la rehidratación: endovenosa enérgica con Ringer lactato si hay shock y luego sales orales. El antibiótico, como doxiciclina o azitromicina en dosis única, solo acorta la diarrea. Es de notificación inmediata.

## 1.04.1.008 Dengue

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Dengue (Aedes aegypti, 4 serotipos): en Chile casos importados y transmisión local en Isla de Pascua; la segunda infección por otro serotipo es la de mayor riesgo de dengue grave.
- Sospecha en viajero: fiebre alta súbita, cefalea retroorbitaria, mialgias y artralgias intensas, exantema con «islas blancas»; la fase crítica (días 3–7) coincide con la caída de la fiebre.
- Signos de alarma (basta uno para hospitalizar): dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, hepatomegalia >2 cm, hematocrito en ascenso con plaquetas <100.000.
- Sin alarma: manejo ambulatorio con hidratación oral, paracetamol y educación de signos de alarma; AINE y aspirina contraindicados. Con alarma: hospitalizar con cristaloides EV. Confirmar con antígeno NS1 (primeros 5 días) o IgM (después del 5.º día).
- Notificación obligatoria inmediata. Seguimiento: derivar los casos con signos de alarma.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Joven de 26 años con 4 días de fiebre hasta 39,5 °C, dolor retroorbitario intenso que empeora con los movimientos oculares, mialgias y artralgias severas. Regresó hace 5 días del noreste de Brasil. T° 38,8 °C, PA 110/70 mmHg, FC 92 lpm. Exantema eritematoso en tronco que respeta pequeñas zonas redondeadas de piel sana. Sin dolor abdominal ni sangrado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Confirmar con NS1 o IgM, manejo ambulatorio con hidratación oral y paracetamol, y educar signos de alarma
> **B)** Hospitalizar e iniciar cristaloides endovenosos
> **C)** Indicar ketoprofeno para las mialgias y control en una semana
> **D)** Solicitar gota gruesa e iniciar arteméter-lumefantrina
> **E)** Iniciar antiviral específico y aislamiento respiratorio
> Respuesta A. Viaje a zona endémica con fiebre, dolor retroorbitario, mialgias y exantema con islas blancas: dengue sin signos de alarma. Se confirma con NS1 o IgM, manejo ambulatorio con hidratación oral y paracetamol, y se educa sobre los signos de alarma. Los AINE están contraindicados; no hay antiviral; sin alarma no se hospitaliza.

## 1.04.1.009 Diarrea asociada a antibióticos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Diarrea asociada a antibióticos: C. difficile es la principal causa, sobre todo tras fluoroquinolonas, clindamicina y cefalosporinas, y en pacientes hospitalizados.

- Sospechar ante diarrea acuosa durante o después de un antibiótico u hospitalización, con dolor abdominal, fiebre, leucocitos fecales y a veces sangre.
- Confirmación: toxinas o PCR de toxina de C. difficile en deposiciones (a menudo con GDH); el coprocultivo habitual no lo detecta y la colonoscopía se reserva para casos dudosos o graves.
- Tratamiento: suspender el antibiótico gatillante si es posible, hidratación y vancomicina oral (o fidaxomicina); el metronidazol queda como alternativa. No usar loperamida.
- Prevención y seguimiento: aislamiento de contacto con lavado de manos con agua y jabón (el alcohol no destruye las esporas), uso racional de antibióticos y control clínico por riesgo de recurrencia.

**PREGUNTAS (6)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 132**

Un paciente es hospitalizado durante 10 días por una neumonía neumocócica adquirida en la comunidad. Algunos días después de ser dado de alta, presenta diarrea líquida abundante, con 5 a 6 evacuaciones al día, asociada a dolor abdominal, malestar general y febrículas hasta 37,3 °C. **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?**

**A)** Colonoscopía
**B)** Parasitológico ampliado de deposiciones
**C)** Coprocultivo
**D)** PCR para Clostridioides difficile
**E)** Ecografía abdominal

Respuesta D. Diarrea que aparece después de una hospitalización con uso de antibióticos obliga a descartar Clostridioides difficile. El examen de elección es la PCR de toxina en deposiciones, que reemplazó a las pruebas de toxina A y B.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 128**

Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al examen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. **¿Cuál es el agente etiológico?**

**A)** Escherichia coli
**B)** Clostridioides (Clostridium) difficile
**C)** Shigella flexneri
**D)** Rotavirus
**E)** Campylobacter jejuni

Respuesta B. Diarrea inflamatoria durante un tratamiento antibiótico obliga a sospechar C. difficile, la principal causa de diarrea asociada a antibióticos (fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas). Se confirma con toxinas o PCR en deposiciones y se suspende el antibiótico si es posible. Hoy se trata con vancomicina oral o fidaxomicina; el metronidazol es alternativa.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 59 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:

**A)** Hidratación por vía oral abundante
**B)** Metronidazol oral
**C)** Ciprofloxacino oral
**D)** Clindamicina ev
**E)** Probióticos orales

Respuesta B. Diarrea por ATB, probablemente por C. difficile. Se trata con MTZ. Eso sí, primero se debería confirmar el diagnóstico con la PCR para Clostridium difficile.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 64 · texto original del banco, sin revisar**

Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:

**A)** Diarrea debida a Clostridium difficile
**B)** Colitis ulcerativa
**C)** Enfermedad de Cröhn
**D)** Colitis inespecífica
**E)** Shigellosis

Respuesta A. Seguro recibió antibióticos en el puerperio, por lo que se sospecha la diarrea por C. difficile. Las otras opciones no tienen relación con el antecedente de puerperio.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente con antecedente de diverticulitis hace 10-15 días tratada con ATB oral (ciprofloxacino + metronidazol), consulta SU por diarrea múltiples episodios, con pujo y tenesmo, fiebre? dolor y sangrado: a. Diarrea por clostridium (sg yo era un cuadro clásico de diarrea por CD 2° a uso de ATB) b. Reagudización de diverticulitis por rectitis c. Absceso diverticular no puede ser CU? - el pujo y tenesmo no orientaría a CU? Vi una similar en una reconstrucción y era CU x eso,, era muy vieja para ser CU

**A)** Staphylococcus aureus
**B)** Streptococcus pneumoniae
**C)** Escherichia coli
**D)** Pseudomonas aeruginosa
**E)** Klebsiella pneumoniae

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Staphylococcus aureus). La insulina es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1 y tiene indicaciones precisas en la diabetes tipo 2. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 43 años es diagnosticada de bronquitis, iniciándose tratamiento con amoxicilina oral por 14 días, con buena respuesta. Al décimo día de tratamiento antibiótico evoluciona con dolor abdominal y diarrea, que en oportunidades es sanguinolenta. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

**A)** Agregar sales de rehidratación oral
**B)** Solicitar parasitológico seriado de deposiciones
**C)** Agregar ciprofloxacino al tratamiento
**D)** Solicitar colonoscopía
**E)** Suspender el tratamiento antibiótico y solicitar toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

Respuesta E. Lo más importante es confirmar el diagnóstico de C. difficile. Sin embargo, las toxinas han sido desplazadas por la PCR (aunque tiene más falsos positivos) y en general no es necesario suspender los antibióticos (en este caso sí se debían suspender, porque no estaban indicados, ya que las bronquitis no se tratan con ATB).

## 1.04.1.010 Enfermedades de transmisión sexual

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas · Tema 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH · Tema 9.19 Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante con incubación de 2–7 días; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares. No gonocócica (Chlamydia 40–50 %, Mycoplasma, Trichomonas): secreción escasa, «gota matinal», Gram solo con PMN.
- Toda uretritis o cervicitis lleva doble cobertura: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días (o azitromicina 1 g dosis única). Ciprofloxacino no: resistencia del gonococo >50 %.
- Úlceras: indolora e indurada = sífilis (penicilina benzatina 2.400.000 UI IM); vesículas en racimo dolorosas = herpes (aciclovir 400 mg c/8 h por 7–10 días); úlcera sucia dolorosa con bubón = chancroide (azitromicina 1 g o ceftriaxona 250 mg IM).
- Condilomas (VPH 6 y 11): podofilotoxina 0,5 %, imiquimod 5 % o crioterapia; en embarazo crioterapia o ácido tricloroacético (podofilina contraindicada). Artritis reactiva post Chlamydia: oligoartritis, uretritis y conjuntivitis con

líquido sinovial estéril.

- Toda ITS obliga a buscar las otras (VIH, sífilis, hepatitis B), tratar a las parejas de los últimos 60 días y abstinencia por 7 días. Seguimiento: control de curación y consejería en preservativo.

**PREGUNTAS (13)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 86**

Mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales de 4 días, con leucorrea. Al examen hay signos inflamatorios en el cuello uterino, con escasa leucorrea. El cultivo de Thayer Martin resulta positivo, y la prueba de aminas, negativa. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Ciprofloxacino
**B)** Ceftriaxona
**C)** Azitromicina
**D)** Doxiciclina
**E)** Penicilina benzatina

Respuesta B. Cultivo de Thayer Martin positivo: cervicitis gonocócica. A pesar de la alergia a penicilina, la ceftriaxona sigue siendo el fármaco de elección para el gonococo.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 136**

Un paciente consulta porque hace 3 días notó aparición de una úlcera en el pene, ubicada en el glande, de 1 cm de diámetro, de aspecto indurado, fondo limpio y sin otros síntomas. Además, se palpa una adenopatía inguinal derecha indolora. Se solicita VDRL y FTA-ABS, resultando ambos negativos. **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Sífilis primaria
**B)** Chancroide
**C)** Enfermedad de Behcet
**D)** Infección por virus papiloma humano
**E)** Linfogranuloma venéreo

Respuesta A. Chancro clásico: úlcera indurada, de fondo limpio, con adenopatía indolora. A los 3 días la serología (treponémica y no treponémica) suele ser aún negativa: período de ventana. El diagnóstico es clínico y la serología se repite.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 36**

Hombre de 25 años con secreción uretral purulenta y disuria de 4 días de evolución. Tinción de Gram: diplococos gram negativos intracelulares. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Azitromicina 1 g oral dosis única
**B)** Doxiciclina 100 mg c/12h por 7 días
**C)** Ciprofloxacino 500 mg oral dosis única
**D)** Amoxicilina 3 g oral dosis única
**E)** Ceftriaxona 500 mg IM dosis única

Respuesta E. Gonorrea uretral: ceftriaxona 500 mg IM en dosis única es el tratamiento de elección del gonococo. Ciprofloxacino y amoxicilina tienen alta resistencia. A la ceftriaxona se agrega doxiciclina o azitromicina para cubrir la Chlamydia concomitante.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 100**

Un paciente de 24 años mantiene relación sexual casual hace 7 días, con penetración vaginal, sin protección evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

**A)** Mycoplasma genitalium
**B)** Ureaplasma urealyticum
**C)** Chlamydia trachomatis
**D)** Trichomona vaginalis
**E)** Escherichia coli

Respuesta C. Uretritis poco sintomática, sin secreción purulenta: uretritis no gonocócica, cuyo agente más frecuente es Chlamydia trachomatis. Mycoplasma, Ureaplasma y Trichomonas pueden darla, pero son menos frecuentes.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 86**

Una mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales, de 4 días de evolución, asociada a leucorrea. Al examen físico, se observan signos inflamatorios en el cuello uterino, con escasa leucorrea. El cultivo de Thayer Martin es positivo y prueba de aminas, negativa. **El tratamiento de elección es:**

**A)** Ciprofloxacino
**B)** Ceftriaxona
**C)** Azitromicina
**D)** Doxiciclina
**E)** Penicilina benzatina

Respuesta B. Cervicitis gonocócica (Thayer Martin es el medio de cultivo del gonococo). El tratamiento de elección del gonococo es la ceftriaxona, y se agrega cobertura para Chlamydia. La prueba de aminas negativa descarta vaginosis bacteriana.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 37**

Hombre de 30 años consulta por úlcera indolora en glande de 5 días de evolución, bordes indurados, fondo limpio. Sin adenopatías inguinales dolorosas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Sífilis primaria (chancro sifilítico)
**B)** Herpes genital
**C)** Chancroide (Haemophilus ducreyi)
**D)** Linfogranuloma venéreo
**E)** Carcinoma espinocelular de pene

Respuesta A. Úlcera genital indolora, de bordes indurados y fondo limpio: chancro sifilítico (sífilis primaria). El herpes es doloroso y vesicular; el chancroide es doloroso y de fondo sucio.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 169**

Una paciente de 19 años consulta por disuria dolorosa y lesiones vulvares, de 48 horas de evolución. Refiere relaciones sexuales sin protección. Al examen genital, tiene 3 úlceras de fondo amarillento y halo eritematoso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Molusco contagioso
**B)** Infección por Chlamydia trachomatis
**C)** Herpes genital
**D)** Chancro sifilítico
**E)** Condiloma acuminado

Respuesta C. Varias úlceras superficiales, dolorosas, sobre halo eritematoso y de inicio agudo: herpes genital. El chancro sifilítico es único e indoloro; la Chlamydia no produce úlceras y el condiloma es una verruga.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 91**

¿Cuál es la conducta más adecuada ante un hombre joven, que presenta múltiples condilomas acuminados perianales? **Elige la alternativa correcta.**

**A)** Descartar otras enfermedades de transmisión sexual
**B)** Determinar el genotipo del virus papiloma
**C)** Realizar rectosigmoidoscopía
**D)** Realizar tratamiento con podofilino
**E)** Indicar aciclovir oral

Respuesta A. Ante toda ITS, lo prioritario es descartar las demás (VIH, sífilis, hepatitis B). Los condilomas por VPH de bajo riesgo no tienen mayores complicaciones y su tratamiento local puede esperar; genotipificar no cambia la conducta.

**Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 44**

Hombre de 26 años consulta por dolor e inflamación en rodilla derecha y tobillo izquierdo de 2 semanas de evolución. Como antecedente refiere un cuadro de uretritis con disuria hace 1 mes tras una relación sexual no protegida. Al examen físico destaca artritis de rodilla derecha y placas hiperqueratósicas indoloras de aspecto descamativo en plantas de pies (queratodermia blenorrágica). La artrocentesis muestra 25.000 leucocitos/mm³ con cultivos negativos. ¿Cuál es el patógeno causante de la infección primaria desencadenante más probable?

**A)** Neisseria gonorrhoeae
**B)** Chlamydia trachomatis
**C)** Treponema pallidum
**D)** Trichomonas vaginalis
**E)** Herpes simplex virus tipo 2

Respuesta B. En el síndrome de artritis reactiva tras exposición sexual (artritis periférica asimétrica + antecedente de uretritis + queratodermia blenorrágica con líquido articular estéril), el agente etiológico primario responsable de la infección urogenital desencadenante es Chlamydia trachomatis. No se trata de una artritis séptica gonocócica, ya que el líquido sinovial es aséptico.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 26 años con úlcera en el glande de 10 días de evolución. Úlcera de 1,5 cm, bordes regulares sobreelevados, base limpia e indurada, indolora, con adenopatía inguinal derecha no dolorosa. VDRL reactivo 1:32. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única
**B)** Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas
**C)** Aciclovir oral por 7 días
**D)** Esperar FTA-ABS antes de tratar
**E)** Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 28 días

Respuesta A. Úlcera única, indurada e indolora con adenopatía indolora y VDRL 1:32: sífilis primaria, es decir precoz. Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única. Además: serología para VIH y hepatitis B, estudio y tratamiento de los contactos sexuales de los últimos 90 días, y VDRL cuantitativo a los 6 y 12 meses.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 22 años, sexualmente activo, con 4 días de disuria intensa y abundante secreción uretral purulenta amarillenta. El Gram de la secreción muestra abundantes polimorfonucleares con diplococos Gram negativos intracelulares. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única
**B)** Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h oral por 7 días
**C)** Ciprofloxacino 500 mg oral en dosis única
**D)** Doxiciclina 100 mg c/12 h oral por 7 días
**E)** Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única

Respuesta B. Diplococos Gram negativos intracelulares confirman la uretritis gonocócica, pero por la coinfección con Chlamydia (hasta 40 %) se trata siempre con doble cobertura: ceftriaxona 500 mg IM + doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días (o azitromicina 1 g). Tratar a los contactos de los últimos 60 días y abstinencia por 7 días.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 61 · texto original del banco, sin revisar**

Un hombre de 34 años consulta por disuria, asociada a secreción uretral purulenta, de un día de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral, observándose abundantes cocáceas Gram negativas intra y extracelulares. El agente etiológico más probable es:

**A)** Neisseria gonorrhoeae
**B)** Treponema pallidum
**C)** Chlamydia trachomatis
**D)** Mycoplasma genitalium
**E)** Streptococcus pyogenes

Respuesta A. Los cocos Gram negativos intra y extracelulares en la secreción uretral purulenta corresponden a Neisseria gonorrhoeae. Se trata con ceftriaxona 250 mg intramuscular en dosis única y, además, se debe cubrir Chlamydia con azitromicina o doxiciclina. Chlamydia no se visualiza con la tinción de Gram.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

**A)** Trichomona vaginalis
**B)** Treponema pallidum
**C)** Ureaplasma urealyticum
**D)** Mycoplasma genitalis
**E)** Chlamydia trachomatis

Respuesta E. Pregunta pésima, puede ser cualquiera de las opciones, menos la B. Sin embargo, la causa más frecuente de uretritis no gonocócica es la Chlamydia trachomatis. Si bien le falta clínica para tener una uretritis (solo tiene disuria, sin secreción uretral), pareciera que es lo que se está preguntando, dadas las alternativas.

## 1.04.1.011 Enfermedades eruptivas no complicadas (varicela, herpes zoster...)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

### QUÉ HAY QUE SABER

- Varicela: exantema pruriginoso centrípeto en «cielo estrellado» (máculas, pápulas, vesículas y costras simultáneas); contagia desde 48 h antes del exantema hasta que todas las lesiones son costras (aislamiento aéreo).
- Niño sano: tratamiento sintomático (antihistamínico, paracetamol); aciclovir oral en mayores de 13 años, segundo caso intradomiciliario o enfermedad crónica. Nunca aspirina (síndrome de Reye).
- Herpes zóster: dolor urente previo y vesículas en un dermatoma unilateral; aciclovir 800 mg 5 veces al día o valaciclovir 1 g c/8 h por 7 días, idealmente antes de 72 h. Zóster oftálmico (signo de Hutchinson) o Ramsay-Hunt: derivación urgente.
- Sarampión: pródromo catarral con conjuntivitis, manchas de Koplik y exantema maculopapular confluente céfalo-caudal; rubéola: exantema rosado tenue de 3 días con adenopatías retroauriculares. Ambos de notificación inmediata.
- Escarlatina (Pastia, Filatov, lengua aframbuesada, piel de lija): amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días. Eritema infeccioso (bofetada, exantema en encaje): sintomático. Seguimiento: control de complicaciones y verificar vacunación PNI.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 118**

Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. **El tratamiento de elección en este caso es:**

**A)** Clorfenamina oral
**B)** Aspirina oral
**C)** Aciclovir oral
**D)** Vacuna contra virus herpes 3
**E)** Inmunoglobulina G no específica

Respuesta C. Varicela en un paciente mayor de 13 años: se indica aciclovir oral, por el mayor riesgo de complicaciones del adolescente y el adulto. La aspirina está contraindicada.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 118**

Hombre de 18 años, sin antecedentes, con 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se asocia a prurito generalizado. Al examen físico destacan lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en el tronco y las extremidades, sin otros hallazgos. **¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso?**

**A)** Clorfenamina oral
**B)** Aspirina oral
**C)** Aciclovir oral
**D)** Vacuna contra virus herpes 3
**E)** Inmunoglobulina G no específica

Respuesta C. Pápulas y vesículas pruriginosas tras un pródromo es una varicela. En mayores de 12 años, que tienen más riesgo de complicaciones como la neumonía, se indica aciclovir oral, idealmente en las primeras 24 horas del exantema. La aspirina está contraindicada por el riesgo de síndrome de Reye; la clorfenamina solo alivia el prurito.

## 1.04.1.012 Fiebre tifoídea y paratifoídea

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

### QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre tifoidea (Salmonella Typhi, reservorio exclusivamente humano, transmisión fecal-oral): fiebre en escalera la primera semana con cefalea y constipación.
- Segunda semana: meseta de 39–40 °C con bradicardia relativa (signo de Faget), roséola tífica, hepatoesplenomegalia y diarrea; hemograma con leucopenia, desviación izquierda y aneosinofilia.
- Confirmación según la semana: hemocultivos en la 1.ª (positivos en 80–90 %), coprocultivo en la 2.ª–3.ª, mielocultivo el más sensible (>95 %, aun con antibiótico previo). El test de Widal no confirma.
- Tratamiento: ceftriaxona 2 g/día EV por 7–14 días o azitromicina 1 g/día oral por 7 días; ciprofloxacino solo si es sensible.
- Complicaciones de la 3.ª semana: perforación ileal y hemorragia digestiva (placas de Peyer). Seguimiento: control clínico, coprocultivos de control y estudio de portación crónica vesicular en manipuladores de alimentos.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 57**

Un niño de 7 años presenta fiebre persistente desde hace 7 días, mayor en la tarde, hasta 38,9 °C, asociada a cefalea, anorexia y dolor abdominal. Al examen físico tiene temperatura: 38,2 °C, frecuencia cardíaca: 62x' y frecuencia respiratoria: 15x'. Se palpa abdomen sensible de manera difusa, sin signos peritoneales. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 35%, glóbulos blancos: 3.700/mm³ con 70% segmentados, 9% cayados, 16% linfocitos, 5% monocitos, 0% eosinófilos y VHS 65 mm/h. Su proteína C reactiva resulta 6,9 mg/L (valor normal: < 0,5 mg/L). **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

**A)** Brucella melitensis
**B)** Salmonella typhi
**C)** Escherichia coli enterotoxigénica
**D)** Virus de Epstein-Barr
**E)** Citomegalovirus

Respuesta B. Fiebre de una semana con cefalea y dolor abdominal, frecuencia cardíaca de 62 con 38,2 °C (bradicardia relativa) y un hemograma con leucopenia, desviación izquierda y sin eosinófilos: el clásico "hemograma tífico". Es fiebre tifoidea por Salmonella Typhi.

## 1.04.1.013 Hidatidosis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

### QUÉ HAY QUE SABER

- Hidatidosis (Echinococcus granulosus): el perro es hospedero definitivo y el humano se infecta al ingerir huevos de sus heces; quistes en hígado (65–75 %, lóbulo derecho) y pulmón (15–25 %, bases).
- Sospecha: masa quística indolora, a menudo hallazgo; en pulmón, vómica de líquido salado con membranas. La eosinofilia puede faltar en el quiste intacto.

- Estudio: ecografía abdominal de elección (vesículas hijas, signo del camalote); radiografía de tórax para el quiste pulmonar; serología (Arco 5 o ELISA IgG) apoya el diagnóstico.
- Complicación más temida: rotura traumática o espontánea con shock anafiláctico y siembra peritoneal; no puncionar el quiste pulmonar.
- Inicial: albendazol 10–15 mg/kg/día y derivar a cirugía (periquistectomía o PAIR en el hepático; cirugía conservadora en el pulmonar). Prevención: no alimentar perros con vísceras crudas y desparasitarlos.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 72**

Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocondrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

**A)** IgG para Toxoplasma gondii
**B)** Serología para hidatidosis
**C)** Serología para Triquinella spiralis
**D)** IgG para Fasciola hepática (Distoma)
**E)** Examen parasitológico seriado de deposiciones

Respuesta B. Lesión hepática quística con pared gruesa: quiste hidatídico. La ecografía ya orienta; la serología apoya el diagnóstico. La ausencia de eosinofilia no lo descarta.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 70**

Un paciente de 34 años presenta un episodio de tos intensa, con salida de abundante líquido salobre, con presencia de membranas blanquecinas y restos hemoptoicos. Su examen físico es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?**

**A)** TAC de tórax y abdomen
**B)** Parasitológico de deposiciones
**C)** Radiografía de tórax
**D)** Ecografía abdominal
**E)** Colonoscopía

Respuesta C. Vómica con líquido salobre y membranas: hidatidosis pulmonar. El primer examen es la radiografía de tórax; luego TAC y ecografía abdominal para buscar quistes hepáticos.

## 1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) · Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Sospechar VIH ante muguet, zóster recurrente, TBC, ITS, neumonía por Pneumocystis o infecciones más graves de lo esperado; la primoinfección da un síndrome mononucleósico con exantema y úlceras orales, a veces con serología aún negativa (ventana).
- Diagnóstico (Ley 19.779: voluntario, confidencial y con consentimiento): tamizaje con ELISA de 4.ª generación o test rápido; un resultado reactivo es preliminar y se confirma con segunda muestra en el ISP. Nunca informar VIH sin confirmación.
- Etapificación CDC: CD4 ≥500, 200–499 o <200; categoría A asintomático, B sintomático no SIDA (muguet, leucoplasia vellosa, zóster), C enfermedad marcadora. SIDA = CD4 <200 o enfermedad definitoria.
- Confirmado: GES; pedir CD4 y carga viral basales. TARV inmediata a todos (Test and Treat), sin importar CD4: tenofovir + lamivudina + dolutegravir en un comprimido diario.
- Inicial: profilaxis con cotrimoxazol forte diario si CD4 <200. Embarazada: TARV de inmediato, lactancia contraindicada y zidovudina al RN. Seguimiento: derivar a centro de atención VIH; I = I con carga viral <50 copias por más de 6 meses.

**PREGUNTAS (9)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 62**

Un paciente de 37 años consulta por fiebre y malestar general de dos días de evolución, asociado a odinofagia. Al examen físico, tiene FC: 96x', PA: 110/70 mmHg, T°: 38,0°C. Se observan úlceras orales, se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa un exantema maculopapular eritematoso con distribución predominante en el tronco. Su examen cardiopulmonar es normal. Al examen neurológico, presenta algún grado de confusión y se palpa rigidez de nuca esbozada. Presenta serología negativa para VIH y para virus de Epstein Barr y se realiza una punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio mononuclear y glucorraquia de 55 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Primoinfección por VIH
**B)** Meningoencefalitis por citomegalovirus
**C)** Meningitis bacteriana aguda
**D)** Neurosífilis
**E)** Mononucleosis infecciosa

Respuesta A. Síndrome retroviral agudo: cuadro mononucleósico con úlceras orales, adenopatías y exantema en el tronco, que puede complicarse con meningitis aséptica (LCR mononuclear, glucosa normal). La serología negativa no lo descarta: el paciente está en el período de ventana.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 56**

Una paciente de 33 años, VIH positivo, cursa un embarazo bien controlado, con tratamiento antirretroviral y cargas virales indetectables. El recién nacido nace a las 38 semanas, por parto vaginal, sin complicaciones. **¿Cuál de los siguientes es el tratamiento antirretroviral de elección para el recién nacido?**

**A)** Zidovudina (AZT)
**B)** Lamivudina (3TC)
**C)** Nevirapina (NVP)
**D)** Lopinavir (LPV)
**E)** Abacavir (ABC)

Respuesta A. El recién nacido hijo de madre con VIH recibe profilaxis antirretroviral por algunas semanas tras el nacimiento; el fármaco de elección es la zidovudina. Además, la lactancia materna está contraindicada.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 57**

Un paciente de 21 años, con antecedente de dermatitis atópica y onicomicosis en manos y pies, es diagnosticado por varicela necrohemorrágica la cual es manejada con aciclovir. **¿Cuál de las siguientes patologías de base es más probable que tenga este paciente?**

**A)** Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina A
**B)** Inmunodeficiencia por alteración en la fagocitosis
**C)** Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina G
**D)** Inmunodeficiencia por déficit de complemento
**E)** Inmunodeficiencia combinada adquirida

Respuesta E. Una varicela grave en un adulto joven, junto con infecciones fúngicas, sugiere un defecto de la inmunidad celular: hay que sospechar infección por VIH y ofrecer el test.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 60**

Un paciente de 36 años presenta desde hace un mes tos irritativa, que se ha vuelto productiva, con expectoración mucosa y últimamente mucopurulenta, asociada a fiebre y malesar general. Al examen está enflaquecido, satura 93% a FiO2 ambiental, tiene FC: 80x', PA: 110/60 mmHg y FR: 21 rpm. A su examen pulmonar, se auscultan crépitos difusos en ambos campos pulmonares, más algunas sibilancias. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con patrón alveolointersticial bilateral difuso). **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

**A)** Streptococcus pneumoniae
**B)** Mycobacterium tuberculosis
**C)** Staphilococcus aureus
**D)** Mycoplasma pneumoniae
**E)** Pneumocystis jiroveci

Respuesta E. Un mes de evolución, paciente enflaquecido, crépitos difusos bilaterales y patrón intersticial bilateral difuso: neumonía por Pneumocystis en un VIH que debuta, aunque el enunciado no lo nombre.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 38**

Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax. **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Fibrosis pulmonar
**B)** Asma bronquial
**C)** Neumonitis viral
**D)** Neumonía por mycoplasma
**E)** Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta E. Cinco semanas de evolución con compromiso bilateral en un paciente enflaquecido: neumonía por P. jiroveci. Con un cuadro más corto y sin baja de peso habría que pensar en Mycoplasma. La fibrosis y el asma son crónicas, con otra radiografía; la neumonitis viral es aguda.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 29 años consulta en APS por astenia y candidiasis orofaríngea (muguet) recurrente. Se realiza un test rápido visual para VIH en el CESFAM, que resulta reactivo. El paciente se angustia y pregunta si ya tiene SIDA y si debe avisar a su familia. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Informar el diagnóstico de VIH e iniciar tenofovir + lamivudina + dolutegravir hoy
**B)** Explicar que el test es preliminar y enviar una segunda muestra venosa al ISP
**C)** Repetir el test rápido en 3 meses por posible período de ventana
**D)** Solicitar CD4 y, si son menores de 200, informar etapa SIDA
**E)** Notificar a la familia para que se realicen el test

Respuesta B. Un test rápido reactivo en APS es solo preliminar. Se contiene al paciente, se explica que el resultado es presuntivo y se envía una segunda muestra venosa al ISP. Confirmado, se activa el GES 18, se piden CD4 y carga viral basales y se inicia de inmediato tenofovir + lamivudina + dolutegravir.

**Pregunta de práctica**

¿Cuál es el esquema antirretroviral de primera línea preferente para el inicio de tratamiento en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de infección por VIH en Chile según la guía ministerial vigente? **Seleccione la alternativa correcta:**

**A)** Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina
**B)** Tenofovir disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir
**C)** Abacavir + Emtricitabina + Lopinavir/Ritonavir
**D)** Efavirenz + Zidovudina + Atazanavir
**E)** Tenofovir alafenamida en monoterapia

Respuesta B. El esquema preferente GES es una tableta única diaria con dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos (tenofovir + lamivudina) y un inhibidor de integrasa (dolutegravir). Reemplazó a los esquemas con efavirenz (efectos neuropsiquiátricos) y zidovudina (mielotoxicidad y anemia).

**Pregunta de práctica**

Hombre de 31 años con VIH y abandono de terapia presenta cefalea holocraneana y hemiparesia faciobraquial derecha de 5 días de evolución. Su recuento de CD4 es de 45 células/mm³. La RMN cerebral con contraste muestra tres lesiones nodulares con captación en anillo y edema circundante localizadas en el tálamo y ganglios basales izquierdos. **¿Cuál es la conducta médica inicial más adecuada?**

**A)** Indicar biopsia estereotáxica urgente de la lesión talámica
**B)** Iniciar radioterapia holocraneana por sospecha de linfoma primario del SNC
**C)** Iniciar tratamiento empírico para Toxoplasmosis con Sulfadiazina + Pirimetamina y evaluar respuesta en 10-14 días
**D)** Administrar anfotericina B liposomal en monoterapia EV
**E)** Indicar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos por 12 meses

Respuesta C. CD4 < 100 con múltiples lesiones en anillo en ganglios basales: toxoplasmosis cerebral. Se inicia tratamiento empírico y se repite la imagen a los 10–14 días; la biopsia se reserva para la falta de respuesta (sospecha de linfoma primario del SNC).

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar**

Emb de 32 semanas con Vih (+) sin tto, cual es la mejor conducta para prevenir transmision vertical:

**A)** Iniciar TARV
**B)** interrumpir embarazo
**C)** TARV intraparto
**D)** Interrupción del embarazo
**E)** Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar TARV (opción A). Diagnóstico: PCR (de elección) o inmunofluorescencia directa; beta-D-glucano es inespecífico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

## 1.04.1.015 Infecciones asociadas a catéteres vasculares

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- Bacteriemia asociada a catéter venoso central: fiebre y calofríos en portador de CVC sin otro foco; el sitio de inserción puede verse limpio. Agentes: S. epidermidis, S. aureus, bacilos gramnegativos y Candida.
- Precoz (<10 días) por vía extraluminal desde la piel; tardía (>10 días) por vía intraluminal desde conectores e infusiones.
- Confirmación: hemocultivos pareados (periférico y de cada lumen); sugiere catéter el mismo germen con positividad del CVC >2 h antes que el periférico, o recuento CVC/periférico ≥3:1.
- Inicial: vancomicina EV; agregar cobertura de gramnegativos (cefepime, piperacilina-tazobactam o amikacina) si hay sepsis o neutropenia.
- Retiro obligatorio del CVC si hay shock, túnel o sitio con pus, complicaciones metastásicas, S. aureus, Candida, Pseudomonas, multirresistentes o bacteriemia persistente a las 48–72 h. S. aureus exige ecocardiograma; Candida, fondo de ojo. Seguimiento: derivar.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 64 años en UCI por pancreatitis aguda grave, con CVC subclavio derecho desde hace 12 días. Presenta bruscamente fiebre de 39 °C con calofríos y taquicardia. Sitio de inserción limpio, sin eritema ni secreción. Hemocultivos pareados: a las 14 horas crece Staphylococcus aureus meticilino-resistente en ambos frascos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Mantener el CVC, iniciar vancomicina y repetir hemocultivos en 72 horas
**B)** Recambiar el CVC sobre guía en el mismo sitio e iniciar cefazolina
**C)** Retirar el CVC, iniciar vancomicina EV y solicitar ecocardiograma
**D)** Sellado del catéter con vancomicina sin antibiótico sistémico
**E)** Retirar el CVC y observar sin antibióticos, ya que el foco fue removido

Respuesta C. Bacteriemia por CVC por S. aureus: retiro obligatorio del catéter aunque el sitio se vea limpio, vancomicina EV ajustada a niveles de valle (es SAMR) y ecocardiograma transtorácico o transesofágico para descartar endocarditis.

## 1.04.1.016 Influenza

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: infecto-25

### QUÉ HAY QUE SABER

- Influenza: inicio brusco con fiebre alta, mialgias, cefalea, odinofagia y tos seca, en brotes invernales; en adultos mayores puede presentarse solo con decaimiento o confusión.
- Confirmación: panel viral por inmunofluorescencia o PCR de hisopado nasofaríngeo, útil en hospitalizados, grupos de riesgo y vigilancia; en brote el diagnóstico es clínico.
- Tratamiento sintomático (paracetamol, hidratación, reposo); no usar aspirina en niños. Oseltamivir 75 mg c/12 h por 5 días, idealmente en las primeras 48 h, en grupos de riesgo (≥65 años, embarazadas, menores de 2 años, enfermos crónicos, inmunosuprimidos) y en todo caso grave u hospitalizado.

- Signos de gravedad: disnea, hipoxemia, compromiso de conciencia, descompensación de enfermedad de base o neumonía bacteriana secundaria (neumococo, S. aureus); hospitalizar con aislamiento por gotitas.
- Prevención: vacuna anual en campaña PNI para grupos de riesgo y personal de salud. Seguimiento: control a las 48–72 h en grupos de riesgo.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 141**

En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta temperatura de 39 °C, con examen pulmonar normal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Oseltamivir
**B)** Zanamivir
**C)** Aciclovir
**D)** Valaciclovir
**E)** Paracetamol

Respuesta E. En un adulto joven sin factores de riesgo ni signos de gravedad, la guía MINSAL indica tratamiento sintomático (paracetamol, reposo e hidratación). El oseltamivir se reserva para grupos de riesgo (embarazadas, adultos mayores, comorbilidades, inmunosupresión) o influenza grave. Aciclovir y valaciclovir actúan sobre herpesvirus, no sobre influenza.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 66 años, hipertenso en tratamiento, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, síntomas que se han hecho más intensos en las últimas horas agregándose cefalea y mialgias intensas. Su examen físico muestra temperatura de 38,5ºC, examen pulmonar sin alteraciones. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

**A)** Acetaminofeno
**B)** Oseltamivir
**C)** Claritromicina
**D)** Zanamivir
**E)** Ibuprofeno

Respuesta A. Es una influenza (adulto mayor). Mayor de 60 años es indicación de oseltamivir. Sin embargo el tratamiento de elección para la influenza es el tratamiento sintomático, además que lleva 3 días, por lo que el oseltamivir es menos efectivo. Ambas son respuestas correctas. Es una pregunta muy discutible, pero si la pregunta es cuál es el tratamiento de la influenza, la respuesta es: paracetamol. No les p

## 1.04.1.017 Leptospirosis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Leptospirosis (Leptospira, en túbulos renales de ratas): contacto con agua estancada, barro o inundaciones contaminados con orina de roedor; entra por piel erosionada o mucosas (agricultores, alcantarillado, arrozales, bañistas).
- Forma anictérica (90 %): fiebre bifásica, cefalea, mialgias intensas de pantorrillas y sufusión conjuntival.
- Síndrome de Weil (10 %): ictericia, insuficiencia renal (a menudo con hipokalemia) y hemorragias; la hemorragia pulmonar es letal. Diferencial: hepatitis o colangitis, que no dan sufusión ni mialgias de pantorrillas.
- Confirmación: serología por microaglutinación (MAT). Leve: doxiciclina oral ambulatoria. Grave (Weil): penicilina G sódica EV o ceftriaxona EV.
- Seguimiento: derivar y hospitalizar las formas ictéricas o con falla renal.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 30 años, trabajador de arrozales con abundantes roedores, inicia hace 6 días fiebre de 39 °C, cefalea, mialgias intensas en las pantorrillas y sufusión conjuntival. Hoy presenta ictericia y oliguria. Creatinina 3,2 mg/dL, bilirrubina total 8 mg/dL, plaquetas 60.000/mm³ y transaminasas levemente elevadas. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?**

**A)** Doxiciclina más rifampicina por 6 semanas
**B)** Albendazol
**C)** Penicilina G sódica o ceftriaxona endovenosa
**D)** Aciclovir endovenoso
**E)** Solo soporte, porque es una hepatitis viral

Respuesta C. Fiebre, mialgias de pantorrillas y sufusión conjuntival tras exposición a agua contaminada con orina de roedores sugiere leptospirosis; ictericia con falla renal es el síndrome de Weil. La forma grave se trata con penicilina G sódica o ceftriaxona endovenosa; la leve, con doxiciclina oral. La hepatitis viral no da sufusión conjuntival ni falla renal.

## 1.04.1.018 Malaria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

### QUÉ HAY QUE SABER

- Malaria (Plasmodium, transmitida por Anopheles): en Chile no hay transmisión autóctona; todos los casos son importados. Pensarla en todo viajero febril desde zona endémica.
- Sospecha: accesos de calofrío, fiebre de 40 °C y sudoración que se repiten, con anemia hemolítica, ictericia y trombocitopenia; la anemia la diferencia del dengue (en este el hematocrito sube).
- P. falciparum es el más letal (malaria cerebral); P. vivax y P. ovale dejan hipnozoítos hepáticos que causan recidivas meses después.
- Diagnóstico de certeza: frotis y gota gruesa con Giemsa, idealmente en el pico febril (trofozoítos en anillo, cuantifica parasitemia). Tratamiento: terapia combinada con artemisinina (arteméter-lumefantrina); vivax u ovale: cloroquina + primaquina 14 días, verificando antes déficit de G6PD.
- Notificación obligatoria inmediata. Seguimiento: derivar a infectología y hospitalizar si es falciparum o hay signos de gravedad.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 147**

Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea intensa y persistente, con marcado malestar general y mialgias. Se realiza un hemograma, que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, glóbulos blancos: 16.000 por mm3, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 93.000 por mm3 y VHS: 35 mmHg. **El agente etiológico más probable es:**

**A)** Viruz zika
**B)** Virus dengue
**C)** Plasmodium falciparum
**D)** Salmonella typhi
**E)** Virus de fiebre amarilla

Respuesta C. La clínica es compatible con dengue, pero la anemia marcada (Hb 8 g/dl, Hto 24%) apunta a hemólisis: malaria. En el dengue que se complica el hematocrito sube, no baja. A la fiebre amarilla le falta la ictericia.

## 1.04.1.019 Micosis invasora (aspergillosis, candidiasis, mucormicosis)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

### QUÉ HAY QUE SABER

- Micosis invasora: en neutropénicos, trasplantados, quimioterapia, diabéticos descompensados o pacientes críticos; se sospecha ante fiebre persistente (4.º–7.º día) pese a antibióticos de amplio espectro con cultivos negativos.
- Aspergilosis pulmonar invasora: tos, hemoptisis y fiebre; la TAC de tórax de alta resolución muestra nódulo o masa con signo del halo.

- Candidiasis invasora: candidemia en portadores de CVC, nutrición parenteral o cirugía abdominal; retirar el catéter y fondo de ojo para descartar endoftalmitis.
- Mucormicosis rinocerebral: diabético (sobre todo con cetoacidosis) con sinusitis, edema facial y necrosis negra del paladar o ala nasal; requiere desbridamiento quirúrgico urgente y anfotericina B.
- Inicial: antifúngico EV empírico (voriconazol para Aspergillus; equinocandina como caspofungina o fluconazol para Candida; anfotericina B liposomal) y no seguir rotando antibióticos. Seguimiento: derivar.

**PREGUNTAS (4)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 73**

Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco, asociado a neutropenia (neutropenia febril), por lo que está en tratamiento con ceftazidima, amikacina y vancomicina, sin mayor respuesta. En sus exámenes de laboratorio presenta neutrófilos 100 por mm3 y en la radiografía de tórax se observa una imagen apical derecha radiopaca, de 3 cm de diámetro, espiculada y con bordes difusos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Tuberculosis
**B)** Neumonía intrahospitalaria
**C)** Aspergilosis invasiva
**D)** Nocardosis
**E)** Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta C. La aspergilosis invasiva es una complicación clásica de la neutropenia prolongada y profunda. Por ser un hongo, no responde a los antibióticos. Se estudia con TC de tórax (nódulo con signo del halo) y galactomanano, y se trata con voriconazol.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 29**

Un hombre de 29 años, presenta un cuadro de tos seca, de 5 semanas de evolución, a lo que se ha agregado disnea y malestar general. Al examen físico destaca FC: 100x', PA: 110/70 mmHg, temperatura: 37,5 grados Celsius y FR: 30x'. El examen cardiopulmonar, así como la radiografía de tórax son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Infección por adenovirus
**B)** Infección por virus influenza
**C)** Infección por Bordetella pertusis
**D)** Infección por Pneumocystis jiroveci
**E)** Infección por Mycobacterium tuberculosis

Respuesta D. Tos seca y disnea de 5 semanas con taquipnea en un adulto joven: evolución subaguda que descarta adenovirus e influenza. La radiografía normal no descarta Pneumocystis en un paciente muy inmunosuprimido; tampoco hay clínica de tuberculosis.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 124**

Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

**A)** Stafilococcus aureus
**B)** Candida albicans
**C)** Streptococcus pyogenes
**D)** Mucor
**E)** Pseudomona aureginosa

Respuesta D. Diabético con sinusitis y necrosis del ala nasal: mucormicosis rinocerebral, una infección oportunista por hongos del huésped inmunocomprometido que no depende del VIH.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 132**

Un paciente, con antecedente de leucemia mieloide crónica, en quimioterapia hace 2 semanas, presenta un cuadro de tos, con expectoración purulenta, con estrías de sangre, asociada a fiebre y malestar general. Se solicitan exámenes, entre los que destaca VHS: 90 mm/h, PCR: 22 mg/L. Se realiza TAC de tórax, que visualiza una tumoración densa, con un halo radiolúcido. **El agente etiológico más probable es:**

**A)** Pseudomona aureginosa
**B)** Aspergillus
**C)** Staphilococcus aureus
**D)** Candida albicans
**E)** Mycobacterium tuberculosis

Respuesta B. Paciente en quimioterapia con tos hemoptoica, fiebre y una masa densa rodeada de un halo en la TAC: aspergilosis pulmonar. Se ve en inmunosuprimidos y en pacientes con lesiones bronquiales previas (bronquiectasias, cavernas tuberculosas).

## 1.04.1.020 Neutropenia febril

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica · Tema 5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

### QUÉ HAY QUE SABER

- Definición: fiebre ≥38,3 °C en una toma o ≥38 °C por más de 1 hora, con RAN <500/mm³ (o <1.000 con caída prevista). RAN = leucocitos × (% segmentados + % baciliformes)/100; nadir 7–14 días post quimioterapia.
- Sin neutrófilos no hay pus ni infiltrado: la fiebre puede ser el único signo. Examinar boca, catéter y zona perianal; tacto rectal y termómetro rectal prohibidos.
- Emergencia: 2 sets de hemocultivos (periférico y de cada lumen del CVC) y antibiótico EV en menos de 60 minutos, sin esperar exámenes ni imágenes.
- Alto riesgo (MASCC <21): hospitalizar en aislamiento con cefepime 2 g c/8 h o piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h EV (meropenem si shock o BLEE); la ceftriaxona no cubre Pseudomonas. Vancomicina solo si hay inestabilidad, infección del catéter, mucositis grave o SAMR. Bajo riesgo (MASCC ≥21): ciprofloxacino + amoxicilina-clavulánico oral con control en 24 h.
- Fiebre persistente al 4.º–7.º día: TAC de tórax y antifúngico empírico (voriconazol o caspofungina). Seguimiento: derivar a hematología u oncología.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 54 años en quimioterapia por linfoma no Hodgkin, último ciclo hace 9 días. Consulta por calofríos. T° 38,6 °C axilar, FC 110 lpm, PA 100/65 mmHg. Sin foco respiratorio, urinario ni abdominal; sitio del catéter venoso central sano. Leucocitos 800/mm³ (15 % baciliformes, 20 % segmentados), plaquetas 65.000/mm³. **Tras tomar 2 hemocultivos, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Hospitalizar en aislamiento y cefepime 2 g c/8 h EV dentro de la primera hora
**B)** Cefepime más vancomicina EV por el catéter venoso central
**C)** Ceftriaxona 2 g EV y control en 24 horas
**D)** Esperar el resultado de los hemocultivos y buscar el foco
**E)** Ciprofloxacino más amoxicilina-clavulánico oral ambulatorio

Respuesta A. RAN = 800 × 35 % = 280/mm³ con fiebre ≥ 38,3 °C: neutropenia febril. Es de alto riesgo y requiere hospitalización en aislamiento y monoterapia antipseudomónica EV (cefepime) en menos de 60 minutos. No hay shock ni infección del catéter, así que la vancomicina de entrada no está indicada.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 53 años con cáncer de mama en quimioterapia con adriamicina y ciclofosfamida (último ciclo hace 10 días). Consulta por fiebre de 38,6 °C y calofríos de 3 horas. Niega tos, disuria o dolor abdominal. PA 115/70 mmHg, FC 102 lpm, T° 37,8 °C. Catéter venoso central implantable sin signos inflamatorios; boca con eritema leve sin úlceras. Hb 9,4 g/dL, leucocitos 800/$\mu$L (segmentados 10%, baciliformes 2%), plaquetas 85.000/$\mu$L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Esperar la radiografía de tórax y el urocultivo para decidir el antibiótico
**B)** Tacto rectal para descartar absceso perianal y luego decidir
**C)** Dos sets de hemocultivos (periféricos y por el catéter) y cefepime 2 g EV en menos de 60 minutos
**D)** Ceftazidima más amikacina y vancomicina EV
**E)** Paracetamol y control en 24 horas, ya que está afebril al examen

Respuesta C. RAN = 800 × 12% = 96/$\mu$L: neutropenia profunda con fiebre en el nadir. Se toman dos sets de hemocultivos (periféricos y por cada lumen del CVC) y se inicia monoterapia antipseudomónica (cefepime 2 g o piperacilina/tazobactam 4,5 g EV) en menos de 60 minutos, hospitalizando en aislamiento protector. El tacto rectal está contraindicado y no se esperan imágenes.

## 1.04.1.021 Osteomielitis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

### QUÉ HAY QUE SABER

- Osteomielitis: infección ósea hematógena (niños, metáfisis de huesos largos; adultos, columna), por contigüidad (pie diabético, úlceras por presión) o postraumática y posquirúrgica. S. aureus es el agente principal.
- Sospecha: dolor óseo localizado, fiebre, impotencia funcional o cojera en el niño; en el pie diabético, úlcera que llega a hueso (sonda que toca hueso) o que no cicatriza. VHS y PCR elevadas.
- La radiografía es normal las primeras 2 semanas; la RM es el examen de elección (también en espondilodiscitis y mal de Pott). Hemocultivos y cultivo de hueso por biopsia o cirugía antes del antibiótico si el paciente está estable.
- Inicial: hospitalizar, hemocultivos y antibiótico EV antiestafilocócico (cloxacilina o cefazolina; vancomicina si se sospecha SAMR o hay antibiograma resistente).
- Seguimiento: derivar a traumatología o cirugía para drenaje o desbridamiento; tratamiento prolongado (habitualmente 4–6 semanas) por especialista.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 161**

Un paciente de 60 años, diabético, consulta por dolor lumbar intenso, de 5 días de evolución, asociado a malestar general y fiebre hasta 38,9°C. Al examinarlo, presenta marcado dolor al presionar la zona vertebral lumbar, con una contractura de la musculatura paravertebral. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Espondilitis anquilosante
**B)** Aplastamiento vertebral
**C)** Lumbago mecánico
**D)** Lumbociática
**E)** Discitis lumbar

Respuesta E. Dolor lumbar intenso con fiebre, malestar general y dolor a la presión de la columna en un diabético: discitis lumbar.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 171**

Un niño de 7 años es hospitalizado para manejo quirúrgico de una osteomielitis. El cultivo informa desarrollo de Staphylococcus aureus, cuyo antibiograma muestra resistencia a oxacilina y a cefalosporinas, con sensibilidad a vancomicina. **¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección para el manejo inicial?**

**A)** Flucloxacilina
**B)** Cefazolina
**C)** Vancomicina
**D)** Tetraciclina
**E)** Cotrimoxazol

Respuesta C. El antibiograma corresponde a S. aureus resistente a meticilina (SARM), que resiste a todos los betalactámicos antiestafilocócicos, incluidas flucloxacilina y cefazolina. En una osteomielitis que requiere hospitalización y cirugía, el tratamiento endovenoso de elección es vancomicina. Las tetraciclinas se evitan en menores de 8 años.

## 1.04.1.022 Parasitosis intestinales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

### QUÉ HAY QUE SABER

- Giardiasis: la más frecuente en preescolares de jardín infantil o zonas rurales, con varios familiares afectados; diarrea crónica esteatorreica y maloliente, flatulencia, distensión y baja de peso, puede simular celiaquía.
- Diagnóstico: parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días distintos, con fijador), ya que la eliminación de quistes es intermitente. Test de Graham ante prurito anal (Enterobius).
- Giardia: tinidazol o metronidazol (alternativa nitazoxanida). Trichuris trichiura (gusanos filiformes en ciego y colon ascendente): mebendazol o albendazol.
- Oxiuros: mebendazol o albendazol con segunda dosis a las 2 semanas y tratamiento de todo el grupo familiar; Ascaris: mebendazol o albendazol.
- Prevención y seguimiento: lavado de manos, agua potable y cocción de alimentos; control parasitológico post tratamiento si persisten los síntomas.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 101**

Paciente de 45 años con diarrea crónica de 6 meses. Se realiza una colonoscopía que muestra parásitos filiformes adheridos a la mucosa del colon ascendente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Giardia lamblia
**B)** Entamoeba histolytica
**C)** Trichuris trichiura
**D)** Ascaris lumbricoides
**E)** Cryptosporidium

Respuesta C. Trichuris trichiura (tricocéfalo) es un nematodo en forma de látigo que se adhiere a la mucosa del ciego y colon ascendente, visible en colonoscopía; causa diarrea crónica y, en infecciones masivas, disentería y prolapso rectal. Giardia vive en el duodeno, Ascaris en el intestino delgado, y los protozoos son microscópicos. Se trata con albendazol o mebendazol.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 25 · texto original del banco, sin revisar**

IMAGEN: Parásito intestinal (foto taenia SAGINATA) tratamiento:

**A)** Mebendazol
**B)** Albendazol
**C)** Praziquantel
**D)** Ivermectina
**E)** Derrame pleural

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Praziquantel (opción C). La hipercolesterolemia familiar es la dislipidemia genética más importante para el EUNACOM De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 28 años consulta ya que lleva varios días eliminando restos de un parásito en sus deposiciones. Se solicita examen parasitológico de deposiciones, que muestra presencia de huevos operculados. ¿Cuál es el antecedente que debe preguntarse dirigidamente para establecer el diagnóstico?

**A)** Consumo de mariscos crudos
**B)** Consumo de sushi de salmón
**C)** Consumo de carne de vaca cruda
**D)** Viaje al caribe
**E)** Contacto con roedores

Respuesta B. Teniasis: La presencia de restos del parásito sugiere una infestación por una tenia. De las tenias, solo el Difilobotrium latum tiene huevos operculados y se transmite por el consumo de pescado crudo. El consumo de carne de vaca cruda puede producir una infestación por Taenia saginata, mientras que la carne de cerdo cruda puede transmitir la Taenia solium. Ambas tienen huevos no operculados.

## 1.04.1.023 Sífilis secundaria, terciaria y congénita

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sífilis secundaria: exantema maculopapular palmoplantar cobrizo (roséola), condilomas planos, placas mucosas y poliadenopatías, semanas después de un chancro indoloro autolimitado.
- Latente: asintomática con serología reactiva, precoz <1 año y tardía >1 año. Terciaria: gomas, aortitis y neurosífilis.
- Sífilis congénita: hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta, pénfigo palmoplantar; se previene con VDRL prenatal y tratamiento oportuno de la madre.
- Confirmación: VDRL o RPR cuantitativo (actividad y seguimiento) más prueba treponémica (FTA-ABS, MHA-TP), que confirma y queda positiva de por vida.
- Inicial: penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dosis única en secundaria y latente precoz; semanal por 3 semanas en tardía o de duración desconocida; embarazada alérgica, desensibilizar. Derivar neurosífilis (penicilina sódica EV), terciaria y congénita (penicilina sódica EV por 10 días).

### PREGUNTAS (4)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 62**

Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Pitiriasis rosada
**B)** Pitiriasis versicolor
**C)** Síndrome pie mano boca
**D)** Sífilis secundaria
**E)** Reacción adversa a la triterapia antirretroviral

Respuesta D. Exantema en tronco con compromiso palmoplantar y de mucosas: sífilis secundaria. Una ITS es el principal factor de riesgo para tener otra.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 130**

Una paciente de 25 años, con antecedente de sífilis tratada hace un año, cursando un embarazo de 8 semanas, se realiza un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/16. **La conducta más adecuada es:**

**A)** Solicitar FTA-ABS
**B)** Controlar con VDRL seriado
**C)** Solicitar RPR
**D)** Administrar ceftriaxona
**E)** Administrar penicilina benzatina

Respuesta E. En quien ya tuvo sífilis, la treponémica seguirá positiva de por vida: lo que indica actividad o reinfección es el VDRL reactivo. Además, todo VDRL reactivo en el embarazo se trata de inmediato con penicilina benzatina.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 26 años con embarazo de 14 semanas presenta VDRL de tamizaje reactivo 1:16, confirmado con FTA-ABS reactivo. Refiere alergia confirmada a la penicilina (shock anafiláctico previo). **¿Cuál es la conducta indicada para prevenir la sífilis congénita?**

**A)** Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días
**B)** Hospitalizar para desensibilización a la penicilina y luego administrar penicilina benzatina
**C)** Eritromicina oral 500 mg cada 6 horas por 14 días
**D)** Diferir todo tratamiento hasta después del parto
**E)** Ceftriaxona 1 g diario intramuscular por 10 días

Respuesta B. La penicilina es el único antibiótico con eficacia demostrada para tratar a la madre y al feto y prevenir la sífilis congénita. La doxiciclina está contraindicada en el embarazo y los macrólidos no cruzan adecuadamente la placenta: se desensibiliza y se trata con penicilina benzatina.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 27 · texto original del banco, sin revisar**

Una mujer embarazada de 8 semanas se toma un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/64. Tiene antecedente de alergia a la amoxicilina. El tratamiento de elección es:

**A)** Penicilina
**B)** Clindamicina
**C)** Ceftriaxona
**D)** Eritromicina
**E)** Doxiciclina

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Eritromicina (opción D). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Penicilina, Clindamicina) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

## 1.04.1.024 Síndrome febril prolongado

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

### QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome febril prolongado: fiebre >38,3 °C por más de 3 semanas sin diagnóstico tras un estudio inicial adecuado.
- Causas: infecciones (clásicamente las más frecuentes: TBC, abscesos, endocarditis), neoplasias (linfomas), enfermedades inflamatorias no infecciosas (arteritis de células gigantes, Still) y misceláneas (fármacos, fiebre facticia).
- Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, perfil bioquímico y hepático, orina completa, hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax y VIH.
- Orientar según la anamnesis epidemiológica (lácteos de cabra: brucelosis; viajes; contacto TBC) y el examen (soplo nuevo, adenopatías, esplenomegalia).
- Inicial: no dar antibióticos empíricos a ciegas en el paciente estable para no negativizar cultivos. Seguimiento: derivar a medicina interna o infectología para estudio dirigido (TAC, ecocardiograma, biopsias).

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 50 años presenta fiebre sobre 38,3 °C de 4 semanas de evolución. Tras una semana de estudio hospitalizada (hemograma, perfil bioquímico, examen de orina, hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax y VIH) no se ha encontrado la causa. **¿Cuál es el grupo de causas clásicamente más frecuente de este síndrome en adultos?**

**A)** Infecciones (como tuberculosis, endocarditis y abscesos)
**B)** Fiebre facticia
**C)** Fármacos, exclusivamente
**D)** Enfermedades genéticas
**E)** Simulación

Respuesta A. Fiebre sobre 38,3 °C por más de 3 semanas sin diagnóstico tras un estudio inicial adecuado define el síndrome febril prolongado. Sus causas se agrupan en infecciones (clásicamente las más frecuentes: tuberculosis, abscesos, endocarditis), neoplasias (linfomas), enfermedades inflamatorias no infecciosas (arteritis de células gigantes, Still) y misceláneas.

## 1.04.1.025 Síndrome mononucleósico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH · Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

### QUÉ HAY QUE SABER

- Mononucleosis por VEB: fiebre prolongada, faringoamigdalitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores, esplenomegalia (50–60 %) y hepatomegalia con alza leve de transaminasas.
- Hemograma con linfocitosis y >10 % de linfocitos atípicos; confirmar con anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell o Monotest) o IgM anti-VCA (IgM VCA positiva con IgG negativa = infección aguda).
- La amoxicilina produce exantema maculopapular en casi todos (inmunocomplejos): suspender sin rotular alergia a penicilina.
- Tratamiento de soporte: paracetamol, hidratación y reposo relativo; evitar deportes de contacto por 3–4 semanas por riesgo de rotura esplénica.
- Heterófilos negativos: CMV (fiebre con faringitis mínima), toxoplasmosis (adenopatía indolora) o primoinfección VIH (úlceras orales y exantema; pedir carga viral). Seguimiento: control hasta resolver la esplenomegalia.

### PREGUNTAS (5)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 164**

Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. **¿Cuál es el agente causal más probable?**

**A)** Adenovirus
**B)** Virus influenza
**C)** Virus de Ebstein Barr
**D)** Citomegalovirus
**E)** Estreptococo A

Respuesta C. Fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales y esplenomegalia en un adolescente: mononucleosis clásica por VEB. La esplenomegalia descarta la faringitis estreptocócica; el CMV cursa con faringitis mínima o ausente.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 152**

Una paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, coriza y odinofagia. Al examen físico destacan amígdalas aumentadas de tamaño con exudado blanquecino adherente, adenopatías cervicales, examen pulmonar normal y abdominal con hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes que muestran lo siguiente: IgM VCA (+), IgG VCA (-), IgM CMV (-), IgG CMV (+), ELISA VIH (-). **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Primoinfección por VIH
**B)** Mononucleosis por Citomegalovirus
**C)** Mononucleosis por Virus Epstein Barr
**D)** Síndrome mononucleósico por estreptococo pyogenes
**E)** Síndrome mononucleósico por leucemia aguda

Respuesta C. IgM VCA positiva con IgG VCA negativa indica infección aguda por VEB. Para CMV, IgG positiva con IgM negativa solo indica infección antigua.

**Pregunta de práctica**

Joven de 19 años con fiebre de 38,5 °C, dolor faríngeo intenso y astenia de 6 días. Hace 3 días le diagnosticaron amigdalitis aguda e indicaron amoxicilina 500 mg cada 8 horas. Tras la cuarta dosis presenta exantema maculopapular eritematoso difuso en tronco y extremidades. Al examen: grandes exudados amigdalinos blanquecinos, adenopatías laterocervicales posteriores sensibles de 2 cm y bazo palpable a 3 cm del reborde costal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Cambiar a azitromicina y rotular alergia a penicilina
**B)** Suspender la amoxicilina, pedir hemograma y Monotest, e indicar reposo sin deportes de contacto
**C)** Aumentar la dosis de amoxicilina por falla terapéutica
**D)** Hospitalizar para penicilina sódica endovenosa
**E)** Solicitar tomografía de cuello por sospecha de absceso periamigdalino

Respuesta B. Faringitis exudativa + adenopatías cervicales posteriores + esplenomegalia + exantema tras amoxicilina: mononucleosis por VEB. Se suspende la amoxicilina (el exantema no es alergia verdadera), se confirma con hemograma (linfocitos atípicos > 10%) y anticuerpos heterófilos o IgM anti-VCA, y se indica reposo relativo 3 a 4 semanas sin deportes de contacto por riesgo de rotura esplénica.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 54 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 23 años consulta por fiebre de 7 días de evolución asociada a odinofagia intensa y malestar general. Al examen Fsico se observa paciente febril, con temperatura: 38,1 °C, frecuencia cardíaca: 100 por minuto y presión arterial: 118/78 mmHg; presenta faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño, se palpan adenopa`as cervicales anteriores bilaterales y, en el examen abdominal, se palpa el hígado 2 cm por debajo del reborde costal. Se solicitan exámenes, destacando: hemograma con hematocrito 39%, hemoglobina 13 g/dL, VCM 88 fL, glóbulos blancos 15.600/mm³ con 70% linfocitos, 20% neutrófilos y 10% monocitos; pruebas hepá8cas con SGOT: 262 U/L, SGPT: 214 U/L, GGT: 90 U/L, fosfatasas alcalinas: 95 U/L y bilirrubina total: 1,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

**A)** Infección por virus hepa22s A
**B)** Leucemia aguda
**C)** Toxoplasmosis aguda
**D)** Mononucleosis infecciosa
**E)** Amigdali2s bacteriana

Respuesta D. Tiene una mononucleosis clásica, con el síndrome mononucleósico (odinofagia, adenopaVas y fiebre), más los elementos clásicos: linfocitosis, hepatoesplenomegalia y hepaGGs (faltó el rash morbiliforme espontáneo o posterior al uso de aminopenicilinas).

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 169 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente 18 años con +7 días? faringe eritematosa, adenopatías, múltiples consultas por el cuadro, le dieron amoxicilina. Al examen físico persiste con adenopatías, tenía un exantema rosado??. Conducta: a. Solicitar Elisa VIH

**B)** IGM anti cápside epstein barr
**B)** Hemograma y VHS
**C)** Ecografía
**D)** Radiografía
**E)** TAC con contraste

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: IGM anti cápside epstein barr (opción B). 90% de las amigdalitis son virales → tratamiento sintomático. Solo las bacterianas requieren antibióticos. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

## 1.04.1.026 Toxicoinfección alimentaria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

### QUÉ HAY QUE SABER

- El tiempo de incubación orienta: <6 h toxina preformada (S. aureus en mayonesa casera o cremas; B. cereus en arroz recalentado), vómitos incoercibles sin fiebre.
- 8–16 h: toxina producida en el intestino (C. perfringens en carnes y guisos recalentados), cólico y diarrea acuosa sin vómitos.
- >16–48 h: invasión bacteriana (Salmonella en huevos, pollo y mayonesa; Campylobacter), con fiebre, dolor y a veces disentería.
- Tratamiento: rehidratación oral o EV y antieméticos (ondansetrón); sin antibióticos en cuadros por toxina. Disentería por Campylobacter: azitromicina (alta resistencia a quinolonas).

- Brote (2 o más personas con la misma comida): notificar a la SEREMI de Salud ante la sola sospecha (vigilancia activa). Seguimiento: controlar hidratación hasta la resolución, habitualmente en 24–72 h.

**PREGUNTAS (4)**

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 76**

Paciente con diarrea disentérica aguda y panel gastrointestinal positivo para Campylobacter. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Ciprofloxacino oral por 3 días
**B)** Metronidazol oral por 7 días
**C)** Cotrimoxazol oral por 5 días
**D)** Amoxicilina oral por 7 días
**E)** Azitromicina vía oral

Respuesta E. Campylobacter es un germen invasor: la disentería justifica antibiótico, y el de elección es la azitromicina oral. Las quinolonas tienen alta resistencia en Campylobacter.

**Pregunta de práctica**

Cuatro miembros de una familia consultan en urgencias por náuseas y vómitos profusos de inicio explosivo hace 3 horas. Almorzaron hace 4 horas pastel de choclo y ensalada rusa con mayonesa casera preparada la noche anterior. Ninguno tiene fiebre ni diarrea. Examen: deshidratación leve y dolor epigástrico por los esfuerzos de vómito. **¿Cuál es el agente más probable y la conducta adecuada?**

**A)** Salmonella enteritidis; ciprofloxacino por 5 días
**B)** Staphylococcus aureus; rehidratación y antieméticos, sin antibióticos
**C)** Clostridium perfringens; metronidazol oral
**D)** Staphylococcus aureus; cloxacilina oral por 7 días
**E)** Vibrio cholerae; doxiciclina 300 mg en dosis única

Respuesta B. Incubación de 1 hora, vómitos predominantes, sin fiebre y mayonesa casera: enterotoxina preformada de S. aureus. Tratamiento de soporte (rehidratación oral fraccionada o cristaloides EV y ondansetrón). No se usan antibióticos: el cuadro lo causa una toxina ya formada y cede en 24 horas.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 52 años con diplopía, ptosis y disfagia de inicio progresivo hace 24 horas, a lo que se agrega debilidad de extremidades superiores. Comió conservas caseras de espárragos el día anterior. Examen: ptosis bilateral, midriasis arreactiva y tetraparesia flácida simétrica con reflejos disminuidos. Sensibilidad normal, afebril. **¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

**A)** Iniciar plasmaféresis por sospecha de síndrome de Guillain-Barré
**B)** Hospitalizar en UCI, monitorizar mecánica ventilatoria y administrar antitoxina botulínica
**C)** Administrar ceftriaxona 2 g EV por sospecha de meningitis bacteriana
**D)** Indicar piridostigmina oral por probable crisis miasténica
**E)** Administrar bolo de metilprednisolona EV por sospecha de esclerosis múltiple

Respuesta B. Conserva casera + pares craneanos + midriasis + parálisis flácida descendente sin compromiso sensitivo: botulismo. UCI por riesgo de falla ventilatoria y antitoxina botulínica precoz. El Guillain-Barré asciende y la miastenia no da midriasis ni disautonomía.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 45 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente adulto con dolor abdominal, diarrea + fiebre x campylobacter, ¿cual es el tratamiento?: a. Azitromicina

**B)** Hidratacion + probioticos
**C)** Ciprofloxacino
**C)** Staphylococcus aureus
**D)** Streptococcus pneumoniae
**E)** Escherichia coli

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: (opción A). Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

## 1.04.1.027 Triquinosis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Triquinosis (Trichinella spiralis): consumo de carne de cerdo o cecinas caseras (longanizas, jamón) faenadas sin inspección veterinaria; las larvas migran al músculo estriado.
- Tríada clásica: edema bipalpebral bilateral (a veces con hemorragias subconjuntivales), mialgias intensas (al masticar, tragar o respirar) y fiebre alta persistente.
- Confirmación: eosinofilia masiva (20–50 %) con CPK y LDH elevadas; serología específica apoya. Diferencial con Chagas agudo (edema palpebral unilateral).
- Tratamiento: albendazol 400 mg c/12 h por 10–14 días (o mebendazol) más analgesia; agregar corticoides si es severa (miocarditis o compromiso sistémico).
- Notificación obligatoria inmediata a la SEREMI para decomisar el alimento y estudiar a los demás expuestos. Seguimiento: control clínico y de CPK y eosinófilos; vigilar miocarditis.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 56**

Un paciente de 25 años que vive en una zona rural consulta por cefalea y mialgias intensas de 7 días de evolución, asociadas a malestar general y sensación febril. Al examen físico presenta temperatura: 37,5 °C, frecuencia cardíaca: 115 por minuto y presión arterial: 100/60 mmHg. Se solicitan exámenes que muestran PCR 5,6 mg/L (valor normal: menor a 0,5 mg/dl), hemograma con 15.000 glóbulos blancos/mm³, 290.000 plaquetas/mm³ y hematocrito de 35%. En la fórmula diferencial de la serie blanca presenta 40% de eosinófilos. Se solicitan CK, que resultan 2.500 U/L (VN: 30-170 U/L). El estudio ecocardiográfico es compatible con miocarditis aguda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Fasciolasis hepática
**B)** Neurocisticercosis
**C)** Hidatidosis
**D)** Infección por Trichinella spiralis
**E)** Infección por virus Coxsackie

Respuesta D. Mialgias + eosinofilia masiva + CK elevada: triquinosis clásica, aquí con miocarditis. Se trata con albendazol y analgésicos, y por la miocarditis se agregan corticoides. El Coxsackie da miocarditis, pero no eosinofilia.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 44 años con 4 días de fiebre de 39 °C, mialgias severas en brazos y piernas que le dificultan caminar y masticar, e hinchazón de ojos. Hace 10 días comió carne de cerdo y longanizas artesanales faenadas en el campo. Edema bipalpebral bilateral con hiperemia conjuntival y dolor a la palpación muscular. Leucocitos 16.200/mm³ con 42% de eosinófilos; CPK 890 UI/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Notificar a la SEREMI e iniciar albendazol 400 mg cada 12 horas por 10 a 14 días
**B)** Solicitar ecografía abdominal y serología para hidatidosis
**C)** Iniciar nifurtimox por sospecha de Chagas agudo
**D)** Iniciar ceftriaxona endovenosa por fiebre tifoidea
**E)** Solo analgesia y control en una semana

Respuesta A. Cecinas caseras sin inspección + edema bipalpebral bilateral + mialgias + fiebre + eosinofilia masiva y CPK alta: triquinosis aguda. Se notifica de inmediato (ENO) y se trata con albendazol 400 mg cada 12 h por 10 a 14 días. El Chagas agudo da edema unilateral.

## 1.04.1.028 Tuberculosis extrapulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

**QUÉ HAY QUE SABER**

- TBC extrapulmonar: 20–25 % de los casos, más del 50 % en VIH; la radiografía de tórax normal no la descarta. Formas más frecuentes: ganglionar y pleural.
- Pleural: exudado unilateral con más de 80 % de linfocitos y ADA >40 UI/L. Ganglionar (escrófula): adenopatías cervicales indoloras y frías que coalescen y fistulizan.
- Meníngea: cuadro subagudo con compromiso de pares III y VI; LCR con linfocitos, glucosa muy baja y proteínas muy altas. Mal de Pott: lumbago o dorsalgia inflamatoria con VHS alta; estudiar con RM.
- Urogenital: piuria estéril con orina ácida y hematuria; cultivo de Koch en orinas matinales seriadas. Confirmar con baciloscopía, cultivo (estándar de oro, da antibiograma), GeneXpert o biopsia.
- Esquema nacional 2RHZE/4RH directamente observado (las formas meníngea y osteoarticular se prolongan). Seguimiento: derivar al Programa de Tuberculosis; vigilar hepatotoxicidad y neuritis óptica por etambutol.

**PREGUNTAS (6)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 71**

Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos días se agrega cefalea y diplopía. Al examen físico destaca reflejo fotomotor conservado, parálisis del sexto par derecho y rigidez de nuca esbozada. Se solicita punción lumbar que muestra células aumentadas de predominio mononuclear, glucosa disminuida y proteínas altas, gram no visualiza gérmenes. **El agente etiológico más probable en este caso es:**

**A)** Mycobacterium tuberculosis
**B)** Neumococo
**C)** Enterovirus
**D)** Herpes virus
**E)** Criptococosis

Respuesta A. Cuadro subagudo con compromiso de pares craneanos (VI par) y LCR con mononucleares, glucosa baja y proteínas altas: meningitis tuberculosa.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 116**

Un paciente de 54 años, con antecedente de artritis reumatoide severa, inicia tratamiento con corticoides sistémicos y terapia biológica, por lo que se realiza estudio de tuberculosis latente con PPD, el que resulta positivo, indicándose tratamiento con isoniacida por 6 meses, permaneciendo asintomático. Un año después consulta por lumbago muy intenso, EVA 8/10, de 10 días de evolución, que ha empeorado en los últimos días y no ha respondido a analgésicos. En el examen físico el dolor limita los movimientos de flexoextensión. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 30% con hemoglobina: 10 g/dL, glóbulos blancos: 12.000/mm³, plaquetas: 480.000/mm³ y VHS: 80 mm/h. La radiografía de tórax es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para evaluar a este paciente?**

**A)** Radiografía de columna lumbar
**B)** Resonancia magnética nuclear lumbar
**C)** Cintigrafía ósea
**D)** ELISPOT
**E)** PET-scan

Respuesta B. Inmunosuprimido con TBC latente conocida, lumbago intenso refractario y VHS 80: sospecha de mal de Pott (espondilodiscitis tuberculosa). Como osteomielitis, el examen de elección es la RM. El ELISPOT es un IGRA, útil en la TBC latente, no para evaluar la columna.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 91**

Paciente con VIH sin TARV, fiebre, baja de peso, hemoptisis, baciloscopías negativas y cultivo MGIT positivo. **¿Cuál es la conducta?**

**A)** Iniciar TARV e investigar otras infecciones oportunistas
**B)** Solicitar broncoscopía y biopsia transbronquial
**C)** Iniciar profilaxis con isoniazida y observar
**D)** Repetir baciloscopías y esperar resultado de cultivo
**E)** Iniciar tratamiento estándar para tuberculosis

Respuesta E. El cultivo es el gold standard: un cultivo MGIT positivo confirma tuberculosis activa aunque las baciloscopías sean negativas. Corresponde el esquema estándar, no la profilaxis.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 118**

Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que se inicia tratamiento con antibióticos asociados. Sus baciloscopías mensuales de control resultan: mes 1 (+), mes 2 (-), mes 3 (-), mes 4 (-), mes 5 (+) y mes 6 (+). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Recaída
**B)** Eliminación esporádica
**C)** Fracaso
**D)** Contaminación
**E)** Nocardiosis pulmonar

Respuesta C. Dos baciloscopías positivas seguidas después del cuarto mes, estando aún en tratamiento, hacen sospechar fracaso. Se confirma con cultivo y antibiograma, y el paciente se deriva a tratamiento secundario mientras tanto.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 8**

Un paciente de 42 años consulta por tos y disnea de 2 semanas de evolución, asociada a expectoración mucopurulenta y, en ocasiones, hemoptoica. Además, ha presentado fiebre ocasional, hasta 38,2°C. Al examen físico presenta estertores bilaterales en ambos campos pulmonares. Se solicitaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas. Además, se solicita otros exámenes, que muestran quantiferón para tuberculosis (+) y PCR para Mycobacterium tuberculosis (+). Su radiografía de tórax se muestra más abajo. **La conducta más adecuada es:**

**A)** Iniciar profilaxis con isoniazida
**B)** Iniciar rifampicina más isoniazida
**C)** Iniciar tratamiento habitual para la tuberculosis
**D)** Solicitar TAC de tórax
**E)** Esperar el resultado del cultivo de Koch y decidir conducta según resultado

Respuesta C. La PCR positiva para M. tuberculosis confirma la enfermedad aunque las baciloscopías sean negativas. Se inicia el tratamiento habitual (esquema primario RHZE). La profilaxis es para contactos sin enfermedad activa.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 21**

Paciente de 35 años VIH (+) con tos productiva de 3 semanas, baja de peso y sudoración nocturna. Baciloscopia de esputo positiva. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

**A)** Isoniazida + Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol por 2 meses, luego Isoniazida + Rifampicina por 4 meses
**B)** Claritromicina + Etambutol por 6 meses
**C)** Moxifloxacino + Rifampicina por 9 meses
**D)** Isoniazida en monoterapia por 9 meses
**E)** Cotrimoxazol forte por 6 meses

Respuesta A. TBC pulmonar activa: esquema 2 HRZE + 4 HR, 6 meses en total, independiente del estado VIH.

## 1.04.1.029 Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: infecto-25

### QUÉ HAY QUE SABER

- COVID-19 leve: fiebre, tos, odinofagia, mialgias, cefalea y anosmia o ageusia, sin disnea ni hipoxemia; moderado si hay neumonía con saturación ≥94 %.
- Confirmación: PCR o test de antígeno en hisopado nasofaríngeo, idealmente en los primeros días de síntomas.
- Tratamiento ambulatorio sintomático: paracetamol, hidratación y reposo; no usar corticoides ni antibióticos sin hipoxemia. Antivirales orales solo en pacientes de alto riesgo según disponibilidad.
- Aislamiento según normativa vigente y educación de signos de alarma: disnea, saturación <94 %, dolor torácico, compromiso de conciencia; especial vigilancia en adultos mayores, inmunosuprimidos y enfermos crónicos.
- Seguimiento: control a distancia en grupos de riesgo, sobre todo entre los días 5 y 10; prevención con vacunación según calendario del PNI.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 30 años, sin comorbilidades y con esquema de vacunación completo, presenta fiebre, odinofagia, tos seca y mialgias de 2 días. El test de antígeno para SARS-CoV-2 es positivo. Saturación 98%, FR 16 por minuto, examen pulmonar normal. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

**A)** Hospitalizar e iniciar dexametasona
**B)** Manejo ambulatorio sintomático, aislamiento y educación sobre signos de alarma
**C)** Azitromicina por 5 días
**D)** Ivermectina
**E)** TAC de tórax y anticoagulación

Respuesta B. COVID-19 leve en un paciente sin factores de riesgo ni hipoxemia se maneja en domicilio con antipiréticos, hidratación, aislamiento y educación sobre signos de alarma (disnea, saturación bajo 94%, compromiso de conciencia). La dexametasona solo beneficia a quienes requieren oxígeno y puede dañar sin hipoxemia. Antibióticos e ivermectina no están indicados.

## Situaciones clínicas de urgencia 11 códigos

### 1.04.2.001 Absceso cerebral

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Absceso cerebral: infección focal supurada del parénquima. Origen por contigüidad en 50 % (sinusitis, otitis crónica, mastoiditis), hematógeno en 30 % (cardiopatía cianótica, endocarditis) o por inoculación directa (TEC penetrante, neurocirugía).
- Sospecha: cefalea, fiebre y déficit focal (la fiebre falta en la mitad), a veces convulsiones; el foco predice la ubicación (seno frontal: lóbulo frontal; oído: temporal o cerebelo).
- Diagnóstico: TAC o RM con contraste muestra lesión con realce en anillo y edema perilesional. Punción lumbar contraindicada por riesgo de herniación.
- Inicial: ceftriaxona 2 g c/12 h EV más metronidazol 500 mg c/8 h EV; agregar vancomicina si hubo trauma o neurocirugía.
- Derivar a neurocirugía: drenaje o aspiración estereotáxica si mide más de 2,5 cm. Seguimiento: por especialista.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 45 años con una sinusitis frontal mal tratada hace 3 semanas consulta por cefalea progresiva, fiebre de 38 °C y paresia del brazo derecho. La TAC de cerebro con contraste muestra una lesión frontal izquierda hipodensa, con captación de contraste en anillo y edema perilesional. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
>
> **A)** Aciclovir endovenoso
> **B)** Corticoides en monoterapia
> **C)** Punción lumbar inmediata para cultivo
> **D)** Radioterapia por sospecha de glioblastoma
> **E)** Ceftriaxona y metronidazol endovenosos, más evaluación neuroquirúrgica para drenaje
>
> Respuesta E. Lesión con captación en anillo, fiebre y un foco contiguo como la sinusitis es un absceso cerebral. Se trata con antibióticos endovenosos que cubran estreptococos y anaerobios, como ceftriaxona más metronidazol, y aspiración o drenaje neuroquirúrgico. La punción lumbar está contraindicada por el efecto de masa.

### 1.04.2.002 Encefalitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Encefalitis: fiebre con alteración de la función cerebral (conducta bizarra, desinhibición, alteración de memoria, afasia, crisis convulsivas focales); signos meníngeos ausentes o leves. El VHS-1 es la causa esporádica más frecuente.
- Pistas temporales: alucinaciones olfatorias o gustativas, afasia de comprensión, crisis focales.
- Confirmación: RM de elección (hiperintensidad temporal en T2/FLAIR; la TAC puede ser normal las primeras 48–72 h); LCR con pleocitosis linfocítica, glucosa normal y eritrocitos; PCR para VHS en LCR (sensibilidad y especificidad >95 %).
- Inicial: aciclovir EV 10 mg/kg c/8 h ante la sospecha, sin esperar RM ni PCR (14–21 días); reduce la mortalidad de >70 % a <20 %. Los antibióticos solos no cubren el virus.
- Si hay convulsiones, focalidad o compromiso de conciencia, TAC antes de puncionar sin retrasar el aciclovir. Seguimiento: derivar y hospitalizar (idealmente UCI).

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 100**

Un paciente de 43 años, presenta un cuadro clínico de fiebre de 4 días de evolución, asociado a cefalea. Hoy se agrega desorientación y confusión, convulsionando en dos oportunidades antes de consultas. La TAC de cerebro muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza punción lumbar, con 130 células por mm3, 85% mononucleares, glucosa: 75 mg/dl (glicemia 90 mg/dl), proteínas 100 mg/dl, con Pandy (+), látex negativo y ausencia de bacterias en la tinción de Gram. Los cultivos están pendientes. **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Meningitis bacteriana aguda
**B)** Meningitis tuberculosa
**C)** Meningoencefalitis herpética
**D)** Meningitis por enterovirus
**E)** Meningitis por VIH

Respuesta C. Compromiso de conciencia y convulsiones con lesión del lóbulo temporal y LCR viral (mononucleares, glucosa normal): meningoencefalitis herpética.

## 1.04.2.003 Endocarditis bateriana

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: cardiologia:4.5

### QUÉ HAY QUE SABER

- Endocarditis infecciosa: sospechar ante fiebre con soplo nuevo, sobre todo en valvulopatía o prótesis, usuarios de drogas EV, portadores de dispositivos o catéteres, o bacteriemia por S. aureus.
- Signos asociados: fenómenos embólicos (ACV, infartos esplénicos o renales), hemorragias en astilla, lesiones de Janeway, nódulos de Osler, manchas de Roth e insuficiencia cardíaca aguda por destrucción valvular.
- Diagnóstico por criterios de Duke: mayores, hemocultivos positivos para germen típico (S. aureus, estreptococos viridans, enterococo) y evidencia ecocardiográfica de vegetación, absceso o nueva insuficiencia valvular.
- Inicial: 3 sets de hemocultivos de sitios distintos antes del antibiótico, ecocardiograma (transtorácico y luego transesofágico) y antibiótico empírico EV si está grave (por ejemplo ampicilina + cloxacilina + gentamicina; vancomicina si es protésica o hay riesgo de SAMR).
- Derivar y hospitalizar: tratamiento EV prolongado (4–6 semanas); la cirugía se indica por insuficiencia cardíaca, absceso, infección no controlada o embolías recurrentes.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 123**

Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T° 38,2 °C, PA 120/80 mmHg y FC 94 por minuto; se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores, y en el examen cardíaco se ausculta un soplo diastólico de intensidad IV/VI. En los exámenes destaca PCR 12 mg/L, VHS 70 mm/h y leucocitosis de 16.000/mm³. Se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas grampositivas en cadena. **¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?**

**A)** Penicilina sódica
**B)** Cloxacilina
**C)** Clindamicina
**D)** Ceftazidima
**E)** Gentamicina

Respuesta A. Endocarditis subaguda en una prótesis valvular tardía con cocáceas grampositivas en cadena (estreptococos del grupo viridans) se trata con penicilina sódica (o ceftriaxona) endovenosa por 6 semanas, a la que puede asociarse gentamicina. La cloxacilina es para estafilococos (cocos en racimos) y la gentamicina sola no es tratamiento.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos. ¿Cuál es el agente más probable en endocarditis infecciosa post-cirugía cardíaca precoz?

**A)** Staphylococcus aureus o S. epidermidis
**B)** Streptococcus viridans
**C)** Enterococcus faecalis
**D)** HACEK group
**E)** Candida albicans

Respuesta A. Endocarditis protésica precoz (<2 meses post-cirugía): causada por gérmenes hospitalarios, principalmente Staphylococcus aureus y S. epidermidis (estafilococos coagulasa negativos), adquiridos intraoperatoriamente.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

**A)** Absceso cerebral
**B)** Tuberculosis meníngea
**C)** Meningitis bacteriana
**D)** Endocarditis bacteriana
**E)** Leucemia mieloide aguda

Respuesta D. Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda; la aguda es menor a 7 días). Ninguna de las opciones puede ser, por no tener relación con la clínica.

## 1.04.2.004 Flegmón submaxilar, submandibular y del piso de la boca

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

### QUÉ HAY QUE SABER

- Angina de Ludwig: celulitis gangrenosa bilateral de los espacios submandibular y sublingual, de origen dental en 80 % (2.º o 3.er molar inferior).
- Sospecha: aumento de volumen submandibular bilateral, piso de boca elevado que empuja la lengua, trismus, voz engolada y estridor.
- El riesgo es la asfixia: lo primero es asegurar la vía aérea (intubación con fibra óptica o traqueostomía); no enviar a TAC sin vía aérea segura.
- Luego antibióticos EV de amplio espectro con cobertura de anaerobios y aseo quirúrgico o drenaje.
- Diferencial: absceso periamigdalino (unilateral, úvula desviada al lado contrario). Seguimiento: derivar de urgencia a cirugía maxilofacial u otorrinolaringología.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 38 años con 48 horas de aumento de volumen doloroso cervical anterior y submandibular bilateral, iniciado tras la extracción del tercer molar inferior izquierdo. Al examen: piso de boca elevado que empuja la lengua contra el paladar, trismus moderado, voz engolada y estridor inspiratorio intermitente. T° 38,9 °C. **¿Cuál es la prioridad inmediata?**

**A)** Asegurar la vía aérea mediante intubación con fibra óptica o traqueostomía
**B)** Solicitar TAC de cuello con contraste para planificar el drenaje
**C)** Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral y analgesia
**D)** Iniciar meropenem, vancomicina y clindamicina EV y observar en sala
**E)** Nebulizar con adrenalina y controlar en 12 horas

Respuesta A. Celulitis bilateral submandibular y sublingual de origen dental con estridor y lengua protruida: angina de Ludwig con riesgo inminente de asfixia. Lo primero es asegurar la vía aérea (fibra óptica o traqueostomía); después, aseo quirúrgico y antibióticos EV.

## 1.04.2.005 Infección invasiva de partes blandas: celulitis, fasceitis, miositis necrotizantes o septicémicas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Fascitis necrotizante: tipo I polimicrobiana (80 %, diabéticos o cirugía perineal; Fournier en el periné) y tipo II por S. pyogenes (jóvenes, trauma menor o varicela).
- Signo precoz: dolor desproporcionado a lo que se ve en la piel, que sobrepasa el borde del eritema. Signos duros: flictenas serohemáticas, crepitación, anestesia cutánea focal y shock séptico.
- Conducta: pabellón inmediato (aseo quirúrgico, fasciotomía y desbridamiento) basado solo en la sospecha clínica; no retrasar por TAC o RM.
- Antibióticos EV en paralelo: meropenem + vancomicina + clindamicina (bloquea la síntesis de toxinas), con reanimación del shock.
- Celulitis simple sin signos duros: cefazolina o cloxacilina EV, marcar el borde del eritema y reevaluar en 12–24 h. Seguimiento: derivar a cirugía.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 172**

Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar un gran tamaño y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg. Además, se aprecia la lesión eritematosa de 20 cm, con zonas violáceas y bulas en su superficie. **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Erisipela
**B)** Herpes zóster
**C)** Pioderma gangrenoso
**D)** Fasceítis necrotizante
**E)** Celulitis bacteriana

Respuesta D. Diabético con lesión extensa, zonas violáceas y bulas, más taquicardia e hipotensión: signos de necrosis con compromiso sistémico. Es una fascitis necrotizante, no una celulitis ni una erisipela.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia la lesión de 20 cm de aspecto eritemato-violáceo, con bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

**A)** Erisipela
**B)** Herpes zóster
**C)** Ántrax
**D)** Fasceítis necrotizante
**E)** Miositis necrotizante

Respuesta D. Diagnóstico: Fasceítis necrotizante (opción D). Es una fasceítis necrotizante clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

## 1.04.2.006 Meningitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Meningitis bacteriana: tríada fiebre, cefalea y rigidez de nuca (completa en menos del 50 %); Kernig y Brudzinski, fotofobia y vómitos. Agentes: neumococo y meningococo (petequias o púrpura).
- TAC antes de la punción solo si hay déficit focal, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión; en ese caso hemocultivos, dexametasona y antibióticos van antes de la imagen.
- LCR bacteriano: >1.000 leucocitos con >80 % PMN, glucosa LCR/suero <0,4 y proteínas 100–500 mg/dL. Viral: mononucleares, glucosa normal (>0,6). TBC: linfocitos, glucosa muy baja y proteínas muy altas.
- Empírico (3 meses a 50 años): dexametasona 10 mg c/6 h EV por 4 días (antes o junto al antibiótico) + ceftriaxona 2 g c/12 h + vancomicina 15–20 mg/kg c/12 h. Mayores de 50, embarazadas o inmunodeprimidos: agregar ampicilina 2 g c/4 h por Listeria.
- Meningococo: notificación inmediata y profilaxis de contactos. Seguimiento: derivar y hospitalizar.

## PREGUNTAS (5)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 37**

Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5ºC, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Meningitis tuberculosa
**B)** Meningitis meningococica
**C)** Meningitis neumocócica
**D)** Meningitis por listeria
**E)** Meningitis herpética

Respuesta B. Cuadro de meningitis bacteriana aguda en una joven. Las petequias y equimosis orientan a meningococcemia: Neisseria meningitidis.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 81**

Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 610 células por mm3, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Ceftriaxona endovenosa
**B)** Cloxacilina endovenosa
**C)** Vancomicina endovenosa
**D)** Imipenem endovenoso
**E)** Ciprofloxacino oral

Respuesta A. LCR bacteriano con diplococos gramnegativos en el Gram: meningococo. Se trata con ceftriaxona endovenosa. El Gram ya identificó el agente, por lo que no se trata de un esquema empírico.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 61**

Un paciente consulta por 5 días de cefalea holocránea intensa, asociada a fiebre hasta 38 grados. En su examen físico se aprecia rigidez de nuca y signo de Brudzinsky esbozados, por lo que se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido con 60 células por mm3, 86% mononucleares, glucorraquia: 0,67 y proteínas de 66 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Meningitis bacterial
**B)** Encefalitis herpética
**C)** Meningitis viral
**D)** Tuberculosis meníngea
**E)** Infección por Listeria monocytogenes

Respuesta C. Pleocitosis moderada mononuclear, razón de glucosa normal (0,67) y proteínas levemente elevadas: meningitis viral. No hay compromiso de funciones cerebrales que sugiera encefalitis herpética.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 54 años con 24 horas de cefalea holocránea, fiebre de 39,2 °C, fotofobia y vómitos. Glasgow 14, sin focalidad, fondo de ojo normal, rigidez de nuca y Brudzinski (+). PL inmediata: LCR turbio, presión 32 cm $H_2O$, 4.200 leucocitos/mm³ (92 % PMN), glucosa 18 mg/dL (glicemia 110 mg/dL), proteínas 280 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado?**

**A)** Ceftriaxona + vancomicina EV
**B)** Dexametasona + ceftriaxona + vancomicina + ampicilina EV
**C)** Aciclovir EV
**D)** Ceftriaxona EV en monoterapia
**E)** Esperar el cultivo del LCR para iniciar antibióticos

Respuesta B. Citoquímico bacteriano típico (PMN > 80 %, razón de glucosa < 0,4, proteínas muy altas). Por ser mayor de 50 años se agrega ampicilina para cubrir Listeria, junto con dexametasona precoz y ceftriaxona + vancomicina.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky, con petequias en extremidades inferiores, asociadas a algunas equimosis. El agente causal más probable es:

**A)** Neisseria meningitidis
**B)** Streptococcus pneumoniae
**C)** Haemophilus influenzae
**D)** Listeria monocytogenes
**E)** Viris herpes simplex

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Neisseria meningitidis). Cuadro clásico de meningococcemia. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

## 1.04.2.007 Sepsis y shock séptico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sepsis (Sepsis-3): infección con disfunción orgánica, aumento agudo del SOFA ≥2. El SIRS ya no define la sepsis.
- qSOFA para alarma en la cabecera (≥2 de 3): FR ≥22, Glasgow <15, PAS ≤100 mmHg. Shock séptico: necesidad de vasopresor para PAM ≥65 y lactato >2 mmol/L pese a volumen adecuado (mortalidad >40 %).
- Primera hora: lactato, 2 hemocultivos de sitios distintos (sin retrasar el antibiótico), antibióticos EV de amplio espectro según foco y cristaloides 30 mL/kg si hay hipotensión o lactato ≥4.
- Si persiste PAM <65 tras volumen: noradrenalina (primera línea, puede iniciarse por vía periférica); dopamina proscrita. Refractario: vasopresina y hidrocortisona 200 mg/día; dobutamina si hay falla de bomba.
- Repetir lactato a las 2–4 h (meta: descenso >20 %); cada hora de retraso del antibiótico aumenta la mortalidad. Seguimiento: derivar a UCI.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 68 años con ITU complicada febril (39 °C), soporoso, PA 82/48 (PAM 59 mmHg), FC 122 lpm, FR 26 rpm. Se administran 2.500 mL de Ringer lactato (30 mL/kg) en 2 horas. Tras la carga, la PA es 84/50 mmHg (PAM 61 mmHg) y el lactato 4,2 mmol/L. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Iniciar noradrenalina EV con meta de PAM ≥ 65 mmHg
**B)** Iniciar dopamina EV en infusión continua
**C)** Administrar hidrocortisona EV antes de cualquier vasopresor
**D)** Repetir otra carga de 2.500 mL de cristaloides
**E)** Esperar el resultado de los hemocultivos para ajustar el tratamiento

Respuesta A. Shock séptico de foco urinario: tras 30 mL/kg persiste PAM < 65 mmHg con lactato > 2 mmol/L. Se inicia noradrenalina EV (meta PAM ≥ 65), junto con hemocultivos y antibióticos de amplio espectro. La dopamina está proscrita y la hidrocortisona se reserva para el shock refractario a noradrenalina.

**Pregunta de práctica**

¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos forma parte del score qSOFA (quick SOFA) para la identificación rápida de sepsis en el servicio de urgencia? **¿Qué parámetro pertenece al qSOFA?**

**A)** Temperatura axilar > 38,3 °C o < 36,0 °C
**B)** Leucocitosis > 12.000/mm³ o baciliformes > 10 %
**C)** Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto
**D)** Frecuencia cardíaca > 90 latidos por minuto
**E)** Diuresis horaria < 0,5 mL/kg/h

Respuesta C. El qSOFA tiene solo tres parámetros clínicos, sin laboratorio: FR ≥ 22 rpm, alteración de conciencia (Glasgow < 15) y PAS ≤ 100 mmHg. Temperatura, taquicardia y leucocitosis eran criterios del antiguo SIRS, abandonado por inespecífico.

## 1.04.2.008 Síndrome pulmonar por Hanta Virus

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

### QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome cardiopulmonar por hantavirus (virus Andes): inhalación de excretas secas del ratón colilargo en recintos rurales cerrados (cabañas, bodegas, leñeras), de Coquimbo a Aysén; letalidad 30–35 %.
- Fase prodrómica de 3–6 días: fiebre alta, cefalea y mialgias intensas de muslos y región lumbar, sin coriza. Luego fase cardiopulmonar: tos seca, disnea rápidamente progresiva, edema pulmonar no cardiogénico y shock.
- Tríada del hemograma: plaquetas <100.000, hematocrito >45–50 % (hemoconcentración) e inmunoblastos >10 %; radiografía con infiltrados bilaterales sin cardiomegalia.
- Inicial: oxígeno, restricción hídrica estricta (nunca bolos de 30 mL/kg), noradrenalina precoz para sostener la presión y monitorización.
- Notificación inmediata ante la sospecha y confirmación con IgM específica (sin esperarla para actuar). Derivar en ambulancia medicalizada a centro con ECMO al inicio de la disnea.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 7**

Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en zona rural del sur de Chile. Hemograma con leucopenia y trombocitopenia. **¿Cuál es el agente causal más probable?**

**A)** Hantavirus (Sin Nombre)
**B)** Leptospira interrogans
**C)** Rickettsia conorii
**D)** Yersinia pestis
**E)** Francisella tularensis

Respuesta A. Trabajo rural en el sur de Chile + fiebre, cefalea, mialgias y compromiso respiratorio progresivo + trombocitopenia: hantavirus. En Chile el agente es el virus Andes, transmitido por el ratón colilargo.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 38 años, trabajador agrícola del Maule, con 4 días de fiebre de 39 °C, cefalea y mialgias intensas en espalda y muslos; hace 6 horas agrega tos seca y disnea progresiva. Hace 2 semanas limpió una bodega deshabitada. PA 90/60 mmHg, FC 115 lpm, FR 28, SatO2 89 %. Rx: infiltrados alveolares bilaterales sin cardiomegalia. Hto 54 %, leucocitos 18.500 con 14 % de inmunoblastos, plaquetas 42.000. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Bolo de cristaloides 30 mL/kg y ceftriaxona endovenosa
**B)** Notificar, oxígeno, aporte hídrico restrictivo y traslado inmediato a centro con ECMO
**C)** Oseltamivir y hospitalización en sala básica
**D)** Esperar la IgM para hantavirus antes de decidir el traslado
**E)** Transfusión de plaquetas y furosemida en bolo

Respuesta B. Exposición en bodega cerrada + fiebre, mialgias y disnea + tríada (Hto 54 %, plaquetas 42.000, inmunoblastos 14 %): síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Notificación ENO inmediata, oxígeno, aporte hídrico restrictivo y traslado en ambulancia medicalizada a un centro con ECMO. La carga de volumen inunda los alvéolos.

**Pregunta de práctica**

Trabajador forestal de 32 años consulta en un hospital de baja complejidad por 3 días de fiebre alta, dolor muscular severo en muslos y sensación de falta de aire. Hemograma: Hto 52 %, leucocitos 16.000/mm³ con 12 % de inmunoblastos, plaquetas 48.000/mm³. **¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas está contraindicada o debe evitarse?**

**A)** Carga masiva de cristaloides con 30 mL/kg en bolo
**B)** Oxigenoterapia con mascarilla de no reinhalación
**C)** Monitoreo estricto de diuresis horaria
**D)** Traslado en ambulancia avanzada con médico
**E)** Toma de serología para IgM específica

Respuesta A. Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: la fuga capilar alveolar hace que los bolos de volumen (como los 30 mL/kg de la sepsis) precipiten un edema pulmonar masivo y asfixia. La guía MINSAL exige manejo hemodinámico restrictivo.

## 1.04.2.009 Tétanos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Tétanos: C. tetani en heridas desvitalizadas (punzantes, quemaduras, fracturas expuestas); la tetanoespasmina bloquea la liberación de GABA y glicina.
- Sospecha: trismus, risa sardónica, rigidez de cuello y abdomen, opistótonos y espasmos dolorosos desencadenados por luz o ruido, con conciencia conservada y habitualmente sin fiebre.
- Inicial: hospitalizar en UCI en box oscuro y silencioso, asegurar la vía aérea (riesgo de espasmo laríngeo), benzodiazepinas o sedación y relajantes musculares.
- Inmunoglobulina antitetánica humana 3.000–6.000 UI para neutralizar la toxina libre, metronidazol EV (o penicilina) y aseo quirúrgico de la herida.
- La enfermedad no deja inmunidad: iniciar vacunación dT. Seguimiento: derivar a UCI.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 68 años, agricultor sin registro de vacunas, se hirió el pie con una herramienta hace 10 días. Consulta por dificultad para abrir la boca, rigidez de cuello y abdomen, y espasmos dolorosos generalizados que se desencadenan con ruidos. Está lúcido y afebril. **Además del aseo quirúrgico de la herida, ¿cuál es el tratamiento más adecuado?**
>
> **A)** Inmunoglobulina antitetánica, metronidazol, benzodiazepinas y manejo en UCI, más inicio de la vacunación
> **B)** Solo vacuna dT
> **C)** Penicilina benzatina y alta
> **D)** Fenitoína por crisis convulsivas
> **E)** Bloqueo neuromuscular ambulatorio
>
> Respuesta A. Trismus, rigidez y espasmos con conciencia conservada es un tétanos generalizado. Se maneja en UCI: inmunoglobulina antitetánica para neutralizar la toxina libre, metronidazol, benzodiazepinas para los espasmos, control de la vía aérea y ambiente tranquilo. La enfermedad no deja inmunidad, por lo que también se inicia la vacunación.

## 1.04.2.010 Varicela complicada: neumonitis, cerebelitis, encefalitis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Neumonitis varicelosa: la complicación más letal; en adultos, embarazadas y fumadores, entre los días 3 y 5 del exantema, con tos seca, disnea súbita, hipoxemia e infiltrados nodulares difusos bilaterales.
- Cerebelitis (ataxia cerebelosa aguda): la neurológica más común en niños, 1–3 semanas post exantema, con marcha atáxica, dismetría y nistagmo; autolimitada, manejo conservador.
- Encefalitis: compromiso de conciencia, convulsiones o focalidad; requiere aciclovir EV y hospitalización. Sobreinfección bacteriana de las lesiones (la más frecuente en niños) puede llegar a celulitis o fascitis por S. pyogenes.
- Inicial en neumonitis o encefalitis: aciclovir EV 10 mg/kg c/8 h y oxígeno; la vía oral es insuficiente. La inmunoglobulina antivaricela sirve como profilaxis post exposición, no como tratamiento.
- Nunca aspirina (síndrome de Reye); aislamiento aéreo. Seguimiento: derivar a hospitalización, UCI en la neumonitis.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 32 años, sano y no vacunado contra la varicela, con 4 días de fiebre y exantema vesicular pruriginoso con lesiones en distintos estadios en cara y tórax. Hace 12 horas agrega tos seca, disnea de reposo rápidamente progresiva y dolor pleurítico bilateral. T° 38,6 °C, FC 118 lpm, FR 32 rpm, SatO2 88% ambiental, crépitos bilaterales difusos. Radiografía: infiltrados micronodulares bilaterales difusos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Aciclovir oral 800 mg 5 veces al día y control en 48 horas
**B)** Hospitalizar en UCI, oxígeno y aciclovir endovenoso 10 mg/kg cada 8 horas
**C)** Ceftriaxona más claritromicina endovenosa
**D)** Inmunoglobulina hiperinmune antivaricela intramuscular
**E)** Metilprednisolona endovenosa en pulsos

Respuesta B. Adulto con varicela activa, insuficiencia respiratoria e infiltrados nodulares difusos: neumonitis varicelosa, la complicación más letal (mortalidad > 20–30%). Requiere UCI, oxígeno y aciclovir EV 10 mg/kg cada 8 horas. La vía oral no alcanza niveles terapéuticos a tiempo; la inmunoglobulina sirve como profilaxis post-exposición, no para la enfermedad establecida.

### 1.04.2.011 Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

#### QUÉ HAY QUE SABER

- COVID-19 grave: disnea, FR >30, saturación <94 % ambiental o infiltrados extensos; crítico si hay SDRA, shock o falla orgánica. Mayor riesgo en adultos mayores, diabéticos, obesos e inmunosuprimidos.
- Confirmación con PCR o antígeno; radiografía o TAC con infiltrados bilaterales periféricos en vidrio esmerilado.
- Con hipoxemia que requiere oxígeno: dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días (reduce la mortalidad) más tromboprofilaxis; oxígeno con meta de saturación 92–96 %.
- No usar hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina ni plasma convaleciente de rutina; tocilizumab solo en casos seleccionados por especialista.
- SDRA: ventilación protectora (6 mL/kg de peso ideal, presión plateau ≤30) y prono ≥16 h/día si PaFi <150. Derivar a unidad de paciente crítico.

#### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 68 años, diabética, cursa su día 8 de COVID-19. Presenta disnea, FR 30 por minuto y saturación de 88% ambiental. La radiografía muestra infiltrados bilaterales periféricos en vidrio esmerilado. Se inicia oxígeno. **¿Cuál de las siguientes terapias ha demostrado reducir la mortalidad en este contexto?**

**A)** Azitromicina
**B)** Hidroxicloroquina
**C)** Dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días
**D)** Ivermectina
**E)** Plasma convaleciente de rutina

Respuesta C. En COVID-19 con hipoxemia que requiere oxígeno o ventilación, la dexametasona 6 mg diarios por hasta 10 días redujo la mortalidad (estudio RECOVERY). Se asocia tromboprofilaxis y, en casos seleccionados, inmunomoduladores como tocilizumab. Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina y plasma convaleciente de rutina no mostraron beneficio.

## Conocimientos generales 13 códigos

### 1.04.3.001 Manejo y prevención de infecciones en personal sanitario

Dónde se enseña: Tema 2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

#### QUÉ HAY QUE SABER

- Precauciones estándar con todo paciente: higiene de manos antes y después de cada contacto, EPP según riesgo y manejo seguro de cortopunzantes (no reencapsular; contenedor rígido cercano).
- Accidente cortopunzante: lavado inmediato con agua y jabón y notificación; ELISA VIH basal del trabajador y controles en día 0, 6 semanas y 3 meses.

- Fuente VIH positiva o desconocida: triterapia profiláctica por 28 días, idealmente en 2–4 h y máximo 72 h, sin esperar la serología de la fuente.
- Contacto con meningococo sin protección (secreciones respiratorias): quimioprofilaxis con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona.
- Personal de salud: vacunación contra hepatitis B e influenza anual; N95 en aislamiento aéreo (TBC, sarampión, varicela).

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. Tras el lavado profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir? **Seleccione la alternativa correcta:**

**A)** Esperar resultado del ELISA del paciente fuente antes de decidir
**B)** Ofrecer de inmediato triterapia antirretroviral profiláctica (PEP) por 28 días a 6 semanas
**C)** Simplemente observar ya que la fuente probablemente es VIH negativa
**D)** Solicitar PCR para VIH al trabajador de salud de inmediato y esperar resultado
**E)** Iniciar monoterapia con zidovudina por 4 semanas

Respuesta B. Con fuente desconocida o seropositiva, la PEP con triterapia se ofrece de inmediato (idealmente < 2–4 horas, máximo 72 horas) por 28 días. No se posterga esperando la serología de la fuente.

## 1.04.3.002 Mordeduras de animales

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica · Tema 2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Aseo profuso con suero a presión: es lo que más reduce la carga bacteriana. Las mordeduras no se suturan de entrada (cierre por segunda intención), salvo en la cara por motivos estéticos, con lavado masivo y antibiótico.
- Gato: colmillos finos que inoculan Pasteurella en profundidad; perro: desgarro y aplastamiento; humana: la más agresiva (Eikenella, anaerobios).
- Amoxicilina-ácido clavulánico es el antibiótico de elección (profiláctico en mano, heridas punzantes, gato, humana o inmunosuprimidos).
- Rabia: perro o gato ubicable, observación del animal por 10 días; no ubicable o vagabundo, vacuna antirrábica inmediata (días 0, 3, 7, 14 y 28); murciélago, vacuna más inmunoglobulina aunque no haya herida visible.
- Profilaxis antitetánica según el esquema previo: la mordedura es herida tetanígena (refuerzo dT si pasaron más de 5 años; dT + IGH-T si tiene menos de 3 dosis).

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 30 años es mordido en el dorso de la mano por su perro, que está vacunado y es observable. Consulta 3 horas después con dos heridas punzantes de 0,5 cm, sin compromiso tendíneo. Tiene esquema antitetánico completo, con refuerzo hace 3 años. **Además del aseo profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Sutura primaria de las heridas y alta sin antibióticos
**B)** Vacunación antirrábica inmediata
**C)** Dejar las heridas abiertas, indicar amoxicilina con ácido clavulánico profiláctica y observar al perro por 10 días
**D)** Cefadroxilo oral y cierre con adhesivo tisular
**E)** Inmunoglobulina antitetánica y vacuna antitetánica

Respuesta C. Las mordeduras en la mano y las heridas punzantes tienen alto riesgo de infección, por lo que no se suturan y se indica amoxicilina con ácido clavulánico, que cubre Pasteurella y anaerobios. Con un perro vacunado y observable no se vacuna contra la rabia: se observa al animal 10 días. Con refuerzo antitetánico hace 3 años no requiere profilaxis.

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. **¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?**

**A)** Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea
**B)** Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato
**C)** Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días
**D)** Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias
**E)** Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

Respuesta B. En Chile el murciélago es el reservorio de la rabia y su mordedura puede pasar inadvertida. Despertar con un murciélago en la habitación es exposición grave: vacunación completa inmediata más inmunoglobulina antirrábica.

## 1.04.3.003 Prevención de enfermedades de transmisión sexual

Dónde se enseña: Tema 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

### QUÉ HAY QUE SABER

- El preservativo usado de forma correcta y consistente en todas las relaciones es la medida más efectiva contra VIH y la mayoría de las ITS; los anticonceptivos hormonales y el DIU no protegen.
- Vacunación contra VPH (PNI escolar) y hepatitis B; tamizaje periódico de VIH y sífilis en personas con conductas de riesgo y en el control prenatal.
- Exposición sexual de riesgo: profilaxis post exposición para VIH con triterapia por 28 días, iniciada lo antes posible y siempre antes de 72 h, más tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B y C.
- PrEP (profilaxis preexposición) para personas con alto riesgo mantenido; I = I: la persona con VIH con carga viral indetectable no transmite por vía sexual.
- Ante toda ITS: buscar las demás, tratar a las parejas sexuales y consejería; reducción del número de parejas.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 24 años consulta 24 horas después de una relación sexual sin preservativo con una pareja ocasional de estado VIH desconocido y con conductas de riesgo. Está asintomática. **Además de la anticoncepción de emergencia y el tamizaje de ITS, ¿cuál es la medida preventiva más adecuada?**

**A)** Penicilina benzatina como única medida
**B)** Esperar una serología de VIH a los 6 meses, sin otra medida
**C)** Vacuna contra el VIH
**D)** Profilaxis post exposición (PEP) para VIH, iniciada antes de 72 horas y mantenida por 28 días
**E)** Ninguna medida, por tratarse de una exposición única

Respuesta D. Tras una exposición sexual de riesgo, la profilaxis post exposición con antirretrovirales debe iniciarse lo antes posible, siempre antes de 72 horas, por 28 días. Se complementa con tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B y C, vacuna de hepatitis B si no está inmunizada, consejería en uso de preservativo y PrEP si mantiene conductas de riesgo.

## 1.04.3.004 Prevención de enfermedades entéricas

Dónde se enseña: Tema 2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

### QUÉ HAY QUE SABER

- Las enfermedades entéricas (diarreas bacterianas y virales, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera) se transmiten por vía fecal-oral.
- Medida poblacional más efectiva: agua potable y eliminación sanitaria de excretas.
- Medidas individuales: lavado de manos, cocción adecuada de alimentos, lavado de verduras, no consumir mariscos crudos ni lácteos sin pasteurizar, y no recalentar guisos o arroz.
- Vacuna de hepatitis A en el PNI. Los antibióticos profilácticos no están indicados.
- Brotes: notificación a la SEREMI ante la sola sospecha para identificar y cortar la fuente; el cólera es de notificación inmediata.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

En una comunidad rural sin red de agua potable se registra un aumento de casos de diarrea aguda y de hepatitis A en niños. **¿Cuál es la medida de prevención más efectiva a nivel poblacional?**

**A)** Antibióticos profilácticos a todos los niños
**B)** Antiparasitarios mensuales a toda la población
**C)** Vacuna BCG
**D)** Suplementación con hierro
**E)** Acceso a agua potable y saneamiento, con lavado de manos e higiene de los alimentos

Respuesta E. Las enfermedades entéricas (diarreas bacterianas y virales, hepatitis A, fiebre tifoidea) se transmiten por vía fecal-oral. Lo más efectivo es el agua potable y la eliminación sanitaria de excretas, junto a lavado de manos, cocción y lavado de alimentos. La vacuna de hepatitis A del PNI refuerza la prevención; los antibióticos profilácticos no están indicados.

## 1.04.3.005 Prevención de infecciones hospitalarias

Dónde se enseña: Tema 2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- Las IAAS se vigilan, previenen y controlan mediante el comité o programa de IAAS de cada hospital; la higiene de manos es la medida más importante.
- Aislamiento de contacto (bata y guantes): SAMR, BLEE, VRE, C. difficile, rotavirus, sarna. En C. difficile usar agua y jabón: el alcohol no destruye las esporas.
- Gotitas (mascarilla quirúrgica, camas a >1 m): meningococo, influenza, coqueluche, parotiditis, rubéola. Aéreo (N95, pieza individual con presión negativa): TBC bacilífera, sarampión y varicela.
- CVC: técnica aséptica, sin antibiótico profiláctico ni recambio programado; retirar en cuanto no sea necesario.
- Sonda Foley: solo con indicación precisa, sistema cerrado y bolsa bajo la vejiga, retirar lo antes posible; no tratar ni pedir de rutina urocultivos en bacteriuria asintomática del portador de sonda.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95?

**Seleccione la alternativa correcta:**

**A)** Meningitis aguda por Neisseria meningitidis
**B)** Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva
**C)** Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile
**D)** Coqueluche por Bordetella pertussis
**E)** Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

Respuesta B. La TBC bacilífera se transmite por núcleos de gotitas < 5 micrones que quedan suspendidos en el aire: aislamiento aéreo con N95 y presión negativa. Meningococo y coqueluche usan gotitas (mascarilla quirúrgica); C. difficile y BLEE, contacto.

## 1.04.3.006 Prevención de infecciones oportunistas en VIH (+)

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

### QUÉ HAY QUE SABER

- La profilaxis primaria depende del recuento de CD4 y se suspende tras la recuperación inmune con TARV.
- CD4 <200 (o <14 %): cotrimoxazol forte 1 comprimido diario contra Pneumocystis; suspender con CD4 >200 por al menos 3 meses.
- CD4 <100 con IgG para Toxoplasma positiva: el mismo cotrimoxazol previene la toxoplasmosis cerebral.
- CD4 <50: azitromicina 1.200 mg semanal contra MAC, hoy solo si no se inicia TARV; suspender con CD4 >100 por 3 meses. PPD ≥5 mm con cualquier CD4: isoniazida 300 mg/día + piridoxina por 9 meses.
- Vacunas: inactivadas indicadas (neumococo, influenza, hepatitis B); vacunas vivas (tres vírica, varicela) contraindicadas con inmunosupresión importante. La mejor prevención es la TARV precoz.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 57**

Un lactante de 12 meses, VIH positivo, con cargas virales detectables, en tratamiento antirretroviral acude a control. **¿Qué vacuna está contraindicada en este paciente?**

**A)** Anti meningocócica conjugada
**B)** Anti neumocócica conjugada
**C)** Anti influenza
**D)** Tres vírica
**E)** Anti SARS CoV2

Respuesta D. La tres vírica (sarampión, paperas, rubéola) es la única vacuna a virus vivo atenuado de la lista. En el paciente con VIH se decide según el grado de inmunosupresión, evaluado con los CD4; con carga viral detectable, se contraindica. Las demás son inactivadas o conjugadas y se indican.

## 1.04.3.007 Profilaxis de endocarditis infecciosa

Dónde se enseña: cardiologia:4.5

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicada solo en cardiopatías de alto riesgo: prótesis valvular o material protésico de reparación, endocarditis previa, cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas o reparadas con defecto residual o en los primeros 6 meses, y trasplante cardíaco con valvulopatía.
- Procedimientos: solo dentales con manipulación de la encía o región periapical o perforación de la mucosa oral; no en endoscopías, procedimientos digestivos o urológicos de rutina.
- Esquema: amoxicilina 2 g oral (niños 50 mg/kg) 30–60 minutos antes del procedimiento.
- Alergia a penicilina: clindamicina 600 mg oral (o azitromicina o claritromicina 500 mg); sin vía oral, ampicilina o cefazolina EV.
- No requieren profilaxis: valvulopatías nativas sin endocarditis previa, prolapso mitral, soplos funcionales ni CIA aislada. La higiene oral y el control dental periódico son la medida preventiva más importante.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 60 años, portador de una prótesis valvular aórtica mecánica, debe someterse a una extracción dental. No tiene alergias. **¿Cuál es la profilaxis de endocarditis infecciosa más adecuada?**

**A)** No requiere profilaxis
**B)** Ciprofloxacino oral
**C)** Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 7 días después del procedimiento
**D)** Amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes del procedimiento
**E)** Vancomicina endovenosa por 5 días

Respuesta D. La profilaxis está indicada en pacientes de alto riesgo (prótesis valvular, endocarditis previa, ciertas cardiopatías congénitas) sometidos a procedimientos dentales con manipulación gingival o periapical. Se usa una dosis única de amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes; en alérgicos, un macrólido. No se recomiendan cursos prolongados posteriores.

## 1.04.3.008 Profilaxis de tétanos

Dónde se enseña: Tema 2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

### QUÉ HAY QUE SABER

- Primero el aseo de la herida; luego dos preguntas: ¿qué herida es (limpia o sucia/tetanígena) y cuántas dosis tiene?
- Esquema completo (≥3 dosis): herida limpia, refuerzo dT si pasaron más de 10 años; herida sucia, refuerzo dT si pasaron más de 5 años.
- Menos de 3 dosis o desconocido: completar esquema dT (3 dosis); si la herida es sucia, agregar inmunoglobulina antitetánica 250 UI IM.
- La vacuna y la inmunoglobulina se administran en sitios anatómicos separados.
- Heridas tetanígenas: punzantes, con tierra o heces, tejido desvitalizado, quemaduras, fracturas expuestas y mordeduras.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 32 años, campesino, sufre una herida punzante profunda en la planta del pie derecho con un clavo oxidado en un establo. Recibió sus vacunas en la infancia, pero no recuerda ningún refuerzo en los últimos 15 años. Examen: herida puntiforme de 1 cm, márgenes desvitalizados y restos de barro. **Además del aseo de la herida, ¿cuál es la conducta antitetánica más adecuada?**

**A)** Refuerzo con vacuna dT, sin inmunoglobulina
**B)** Vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica 250 UI
**C)** Solo inmunoglobulina antitetánica 250 UI
**D)** No requiere profilaxis por su vacunación infantil
**E)** Inmunoglobulina antitetánica 3.000 UI y metronidazol EV

Respuesta A. Herida tetanígena (punzante, con barro y tejido desvitalizado) en un paciente con esquema completo en la infancia (≥ 3 dosis) y último refuerzo hace más de 10 años: refuerzo con dT. La IGH-T se reserva para herida sucia con esquema incompleto o desconocido.

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 45 años consulta tras cortarse la mano con una lata oxidada en su patio. Su esquema de vacunación contra el tétanos está al día, habiendo recibido su última dosis de refuerzo hace 3 años. **¿Cuál es la indicación correcta?**

**A)** Aseo quirúrgico local de la herida sin necesidad de vacuna ni inmunoglobulina
**B)** Administrar refuerzo con toxoide tetánico (dT)
**C)** Administrar inmunoglobulina antitetánica (IGH-T) en dosis de 250 UI
**D)** Administrar vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica
**E)** Iniciar profilaxis antibiótica con ciprofloxacino por 10 días

Respuesta A. Esquema completo con última dosis hace menos de 5 años: la protección es suficiente incluso ante una herida sucia. Solo se requiere aseo prolijo de la herida.

## 1.04.3.009 Profilaxis de tuberculosis

Dónde se enseña: Tema 2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes · Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- Ante todo contacto de un caso bacilífero, primero descartar TBC activa con síntomas, radiografía de tórax y baciloscopías; si está enfermo, se trata con el esquema completo.
- Contactos menores de 15 años o con VIH: isoniazida 10 mg/kg/día (máximo 300 mg) de entrada, sin esperar el PPD; se repite el PPD al tercer mes: si es negativo se suspende y si vira se completan 6 meses.
- Adultos: terapia preventiva si el PPD es ≥10 mm (≥5 mm en VIH o inmunosuprimidos) y se descartó enfermedad activa; 6 meses (9 meses en VIH); el embarazo no la contraindica.
- Recién nacido de madre bacilífera: isoniazida por 6 meses, BCG al terminar la quimioprofilaxis y lactancia materna con mascarilla quirúrgica materna.
- Antes de terapia biológica o corticoides prolongados, tamizaje de TBC latente (PPD o IGRA); agregar piridoxina en diabéticos, desnutridos, alcohólicos, embarazadas y VIH.

### PREGUNTAS (4)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 142**

¿Cuál es la conducta más adecuada para un paciente, que es contacto intradomiciliario de otro individuo diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera? **Seleccione la alternativa correcta:**

**A)** Solicitar PPD y cultivo de expectoración
**B)** Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías
**C)** Controlar clínicamente por 3 meses
**D)** Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses
**E)** Solicitar cultivo de Koch y broncoscopía

Respuesta B. El primer paso con todo contacto es descartar tuberculosis activa: síntomas, radiografía de tórax y baciloscopías. Recién después se decide la profilaxis (de entrada en menores de 15 años; según PPD en adultos).

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 16**

Una paciente de 30 años, asintomática, está cursando un embarazo de 20 semanas. Su marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías de expetoración que resultaron (+++). La mujer se realiza baciloscopías, que son negativas y un PPD que resulta 26 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada para con ella?**

**A)** Mantener una conducta expectante como protección fetal
**B)** Iniciar tratamiento con 4 fármacos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol).
**C)** Repetir las baciloscopías periódicamente
**D)** Administrar la vacuna BCG
**E)** Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses

Respuesta E. Adulta asintomática, con baciloscopías negativas (sin TBC activa) y PPD > 10 mm tras contacto bacilífero: profilaxis con isoniazida por 6 meses. El embarazo no la contraindica.

**Pregunta de práctica**

Recién nacido de término, sano, de 2 días de vida. A su madre se le diagnostica tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva durante la hospitalización del puerperio. El niño está asintomático, con examen físico normal. Aún no ha recibido la vacuna BCG. **¿Cuál es la conducta más adecuada con el recién nacido?**

**A)** Vacunar con BCG hoy y suspender la lactancia materna
**B)** Isoniazida por 6 meses, postergar la BCG y mantener la lactancia con mascarilla materna
**C)** Isoniazida por 6 meses junto con la BCG hoy
**D)** Solicitar PPD y decidir la isoniazida según el resultado
**E)** Separar al niño de la madre hasta que ella negativice la baciloscopía

Respuesta B. Hijo de madre con TBC activa bacilífera: tres medidas simultáneas. Isoniazida por 6 meses, BCG al término de la quimioprofilaxis (la isoniazida neutraliza el bacilo vacunal) y lactancia materna con mascarilla quirúrgica materna.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 39 años, inmigrante, VIH positiva sin tratamiento desde hace 2 años, consulta por síntomas respiratorios, que comenzaron hace 3 semanas, consistentes en tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y malestar general. Ha utilizado amoxicilina automedicada, sin respuesta. Al examen físico está enflaquecida. El examen pulmonar se auscultan estertores y crépitos en el lóbulo superior derecho. Se solicita PPD, que resulta 5 mm; baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; y se toma cultivo líquido MGIT, que resultó positivo a los 15 días. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radio): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

**A)** Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis
**B)** Iniciar tratamiento estándar para la tuberculosis
**C)** Esperar el resultado del cultivo estándar para mycobacterias
**D)** Reiniciar la triterapia antirretroviral
**E)** Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis (opción A). Baciloscopías de expectoración: examen de elección; pedir 3-4; sensibilidad 80%; muestra válida si > 50 neutrófilos/campo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

## 1.04.3.010 Profilaxis en contactos de infecciones meningocócicas

Dónde se enseña: Tema 2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

### QUÉ HAY QUE SABER

- La enfermedad meningocócica es de notificación inmediata para identificar a los contactos y darles quimioprofilaxis a tiempo, idealmente antes de 24 h.
- Contactos que la reciben: convivientes y quienes pernoctaron bajo el mismo techo en los últimos 7 días, contactos de sala cuna o jardín infantil y personal de salud expuesto a secreciones sin protección. Los compañeros de curso escolar no la requieren de rutina.
- Rifampicina 600 mg c/12 h por 2 días (niños 10 mg/kg c/12 h).
- Alternativas: ciprofloxacino 500 mg VO dosis única en adultos; ceftriaxona 250 mg IM dosis única, de elección en embarazadas.
- No se espera a que el contacto tenga fiebre; la profilaxis busca erradicar la portación.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Escolar de 9 años es hospitalizado por meningococcemia. Vive con sus padres y un hermano de 6 años. Una compañera de curso se sentó a su lado en clases, sin contacto con sus secreciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la quimioprofilaxis?**

**A)** Indicarla a todo el colegio con amoxicilina
**B)** Indicarla a los contactos intradomiciliarios, idealmente en las primeras 24 horas, con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona
**C)** Indicarla solo al personal de salud que lo atendió
**D)** Indicarla a los contactos solo si presentan fiebre
**E)** No indicarla, porque basta con vacunar

Respuesta B. La quimioprofilaxis se indica a contactos íntimos: convivientes, contactos de sala cuna o jardín infantil y personal de salud expuesto a secreciones sin protección, idealmente antes de 24 horas. Se usa rifampicina por 2 días, ciprofloxacino en dosis única en adultos o ceftriaxona en dosis única. Los compañeros de curso escolares no la requieren de rutina.

## 1.04.3.011 Uso y abuso de antibióticos

Dónde se enseña: Tema 2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- Usar antibióticos solo con indicación precisa, en dosis y duración adecuadas; el abuso selecciona resistencia (SAMR, BLEE) y favorece la infección por C. difficile.
- No tratar la bacteriuria asintomática salvo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa; tampoco en portadores de sonda.
- No dar antibióticos en cuadros virales ni en intoxicaciones alimentarias por toxina preformada; no usar antibiótico profiláctico en CVC.
- Antes de iniciar antibióticos en infecciones graves, tomar cultivos (sin retrasar el tratamiento) y luego ajustar al antibiograma (desescalar).
- Nunca agregar un solo fármaco a un esquema que está fallando (por ejemplo en TBC): genera más resistencia.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 120**

Un paciente incia tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, por una tuberculosis pulmonar. Al séptimo día de tratamiento presenta vómitos y dolor abdominal luego de recibir los fármacos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Agregar omeprazol al tratamiento
**B)** Retirar uno de los 4 fármacos
**C)** Suspender el tratamiento y solicitar pruebas hepáticas
**D)** Derivar para tratamiento secundario
**E)** Mantener el tratamiento

Respuesta C. Vómitos y dolor abdominal tras los fármacos obligan a sospechar hepatotoxicidad, la reacción adversa más frecuente del esquema (isoniazida, rifampicina y sobre todo pirazinamida). Se suspende y se confirma con pruebas hepáticas.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 38**

Una paciente de 33 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de dolor lumbar y fiebre desde hace un día, asociado a disuria y orinas de mal olor. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con temperatura de 38ºC y en el resto del examen solo destaca puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina y urocultivo, con lo que se confirma pielonefritis aguda por lo que inicia tratamiento ambulatorio con ciprofloxacino. Dos días después acude a control persistiendo sintomática. Su resultado del urocultivo muestra presencia de echericha coli sensible a nitrofurantoina, carbapenémicos, ampicilina/sulbactam y amikacina, y resistente a cefalosporinas, gentamicina y ciprofloxacino. **¿Cuál de los siguientes fármacos es el de elección para el manejo en este caso?**

**A)** Amikacina
**B)** Nitrofurantoina
**C)** Ertapenem
**D)** Ampicilina
**E)** Moxifloxacino

Respuesta C. Una E. coli resistente a cefalosporinas es una BLEE: el tratamiento de elección es un carbapenémico (ertapenem 1 g al día). La nitrofurantoína no alcanza el parénquima renal y el moxifloxacino comparte la resistencia a quinolonas.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 33**

Adulto mayor de 78 años con sonda Foley permanente. Un urocultivo de rutina informa E. coli >100.000 UFC/mL. El paciente está asintomático y afebril. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** No tratar: la bacteriuria asintomática en portador de sonda no requiere antibióticos
**B)** Iniciar nitrofurantoína por 7 días
**C)** Iniciar ciprofloxacino por 7 días
**D)** Cambiar la sonda y tratar con cefazolina
**E)** Repetir el urocultivo en 48 horas

Respuesta A. Casi todos los portadores de sonda permanente tienen bacteriuria. Sin síntomas no se trata: el antibiótico no da beneficio, selecciona resistencia y favorece C. difficile; tampoco deben pedirse urocultivos de rutina. La bacteriuria asintomática solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa.

## 1.04.3.012 Vacunas especiales (neumococo, influenza, hepatitis A y B, varicela, rabia, meningococo)

Dónde se enseña: Tema 2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

### QUÉ HAY QUE SABER

- Esplenectomía: vacunar contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae b al menos 2 semanas antes de la cirugía programada (o 2 semanas después si fue de urgencia), más influenza anual.
- Influenza: anual a mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos, niños pequeños y personal de salud. Neumococo: adultos mayores y enfermos crónicos o inmunosuprimidos.
- Hepatitis B en personal de salud y grupos de riesgo; hepatitis A en el PNI y en riesgo de exposición.
- Rabia: mordedura de perro o gato no ubicable, vacuna de 5 dosis (días 0, 3, 7, 14 y 28); contacto con murciélago, vacuna más inmunoglobulina antirrábica, aunque no haya herida visible. Animal ubicable: observación veterinaria por 10 días.
- Vacunas vivas (varicela, tres vírica, fiebre amarilla) contraindicadas en embarazo e inmunosupresión importante; las inactivadas y conjugadas sí se indican.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 40 años será sometido a una esplenectomía electiva por un púrpura trombocitopénico inmune refractario a tratamiento médico. **¿Qué vacunas se deben indicar, idealmente al menos 2 semanas antes de la cirugía?**

**A)** Solo la vacuna contra la influenza
**B)** BCG y fiebre amarilla
**C)** Neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b
**D)** Rabia y hepatitis A
**E)** Ninguna; se vacuna solo si presenta infecciones después de la cirugía

Respuesta C. El asplénico tiene riesgo de sepsis fulminante por bacterias capsuladas: neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b. Se vacuna al menos 2 semanas antes de la esplenectomía programada, o 2 semanas después si fue de urgencia, y se agrega influenza anual. Las vacunas vivas como la BCG no tienen indicación aquí.

## 1.04.3.013 Vacunas incluidas en el PNI (Plan Nacional de Inmunizaciones)

Dónde se enseña: Tema 18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

### QUÉ HAY QUE SABER

- Calendario PNI: recién nacido BCG y hepatitis B; 2, 4 y 6 meses hexavalente (más neumocócica conjugada a los 2 y 4 meses); 12 meses tres vírica, meningocócica y refuerzo neumocócico; 18 meses hexavalente, hepatitis A y varicela.
- Vivas atenuadas (BCG, tres vírica, varicela): contraindicadas en embarazo e inmunosupresión grave (corticoides en dosis alta); las inactivadas o conjugadas son seguras.
- Falsas contraindicaciones: resfrío o fiebre baja, antibióticos en curso, alergia al huevo (no contraindica tres vírica ni influenza) y prematurez (se vacuna por edad cronológica; la BCG espera los 2.000 g).
- Embarazada: influenza inactivada en campaña y dTpa desde la semana 28; la tres vírica se posterga al posparto.
- Además: nirsevimab (anticuerpo, no vacuna) contra VRS en menores de 6 meses, VPH en escolares, influenza anual a grupos de riesgo y neumocócica polisacárida en adultos mayores.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Una mujer de 26 años, con 12 semanas de embarazo, consulta por su calendario de vacunas. No recuerda haber recibido la vacuna contra el sarampión. **¿Cuál de las siguientes vacunas del PNI es de virus vivos atenuados y está contraindicada durante el embarazo?**
> **A)** Tres vírica (sarampión, rubéola y parotiditis)
> **B)** dTpa
> **C)** Influenza inactivada
> **D)** Hepatitis B
> **E)** Neumocócica conjugada
> Respuesta A. La tres vírica es de virus vivos atenuados y está contraindicada en el embarazo; se administra en el postparto. En la gestante, el PNI indica influenza inactivada en campaña y dTpa desde la semana 28, para proteger al recién nacido de la tos convulsiva. Las vacunas inactivadas son seguras en el embarazo.

## Exámenes e imagenología 16 códigos

### 1.04.4.001 Antigenemia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Antigenemia pp65 de CMV: detecta antígeno viral en leucocitos de sangre periférica y cuantifica la replicación activa; hoy se reemplaza progresivamente por la PCR cuantitativa (carga viral) de CMV.
- Indicaciones: trasplantados de órgano sólido o médula, VIH avanzado (CD4 <50) y otros inmunosuprimidos con fiebre, citopenias, hepatitis, neumonitis, colitis o retinitis sugerentes de CMV.
- Interpretación: resultado positivo indica infección activa (replicación); recuentos altos o en ascenso se asocian a enfermedad y orientan a tratamiento con ganciclovir o valganciclovir; recuentos seriados sirven para monitorizar la respuesta.
- Se usa en estrategia anticipada (pre-emptive): monitorización periódica post trasplante e inicio de tratamiento antes de que aparezca la enfermedad.
- Limitaciones: requiere procesar la muestra en pocas horas y no es útil con neutropenia profunda (pocos leucocitos); la serología IgG positiva solo indica infección pasada y no sirve para este fin.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Un hombre de 50 años, con trasplante renal hace 2 meses y en tratamiento inmunosupresor, presenta fiebre, leucopenia, alza de transaminasas y deterioro de la función renal. **¿Cuál es el examen más útil para confirmar precozmente la sospecha diagnóstica?**
> **A)** Serología IgG para citomegalovirus
> **B)** Hemocultivos aeróbicos
> **C)** Antigenemia pp65 o carga viral (PCR) de citomegalovirus en sangre
> **D)** Gota gruesa
> **E)** Test de tinta china
> Respuesta C. El citomegalovirus es la infección oportunista más frecuente entre el primer y sexto mes post trasplante: fiebre, leucopenia, hepatitis y disfunción del injerto. Se diagnostica con antigenemia pp65 (antígeno viral en leucocitos) o PCR cuantitativa en sangre, que también guían la terapia con ganciclovir. La IgG solo indica infección pasada.

### 1.04.4.002 Cultivo de heridas o abscesos

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: abscesos, infecciones de herida operatoria, pie diabético o mordeduras infectadas, sobre todo si hay riesgo de gérmenes resistentes o falla del tratamiento empírico.

- Toma correcta: limpiar la superficie con suero y obtener aspirado de pus o biopsia de tejido profundo; las tórulas superficiales y los apósitos se contaminan con flora colonizante y dan resultados poco confiables.
- Enviar rápido al laboratorio, idealmente antes de iniciar antibióticos; solicitar cultivo para anaerobios si la muestra es profunda o con olor fétido.
- Interpretación: el Gram orienta la terapia inicial (cocos Gram positivos en racimos: estafilococo); el antibiograma permite ajustar, por ejemplo vancomicina si es SAMR (resistente a oxacilina).
- Flora cutánea habitual en una tórula superficial suele ser contaminación; el tratamiento base del absceso sigue siendo el drenaje.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 62 años, diabética, presenta al 6° día postoperatorio una herida abdominal con eritema, induración y salida de pus. Se abre la herida y se drena. **¿Cuál es la forma más adecuada de obtener una muestra para cultivo?**

**A)** Tórula superficial de la piel alrededor de la herida
**B)** No tomar cultivos en infecciones de herida
**C)** Cultivo de la gasa del apósito
**D)** Hemocultivos solamente
**E)** Aspirado de pus o biopsia de tejido profundo, tras limpiar la superficie

Respuesta E. El cultivo de heridas y abscesos se toma por aspiración del pus o biopsia de tejido profundo, previa limpieza de la superficie con suero, para evitar la flora colonizante de la piel. Las tórulas superficiales y los apósitos dan resultados poco confiables. La muestra se envía rápido al laboratorio, idealmente antes de iniciar antibióticos.

## 1.04.4.003 Cultivos de hongos

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: confirmar onicomicosis, tiñas extensas o de cuero cabelludo y lesiones dudosas antes de un tratamiento oral prolongado; hasta la mitad de las distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, trauma, liquen).
- Examen micológico directo con KOH: resultado rápido, muestra hifas o levaduras; el cultivo (Sabouraud) tarda semanas pero identifica el agente (dermatofito, levadura o moho) y orienta el fármaco.
- Toma: raspado del borde activo de la lesión o del lecho ungueal distal, sin antimicóticos tópicos las semanas previas.
- Interpretación: dermatofito confirma tiña u onicomicosis tratable con terbinafina (12 semanas en uñas de pies); Candida orienta a azoles; un cultivo negativo con KOH positivo no descarta.
- Un resultado negativo con clínica dudosa obliga a reconsiderar el diagnóstico antes de exponer al paciente al costo y riesgo hepático del tratamiento sistémico.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 55 años consulta por engrosamiento, color amarillento y desprendimiento distal de las uñas de ambos ortejos mayores, de 2 años de evolución. Desea tratamiento oral. **¿Cuál es la conducta más adecuada antes de iniciar terbinafina oral?**

**A)** Iniciar terbinafina sin estudio
**B)** Confirmar con examen micológico directo (KOH) y cultivo de hongos de la uña
**C)** Biopsia de la matriz ungueal en todos los casos
**D)** Radiografía del ortejo
**E)** Hemocultivos

Respuesta B. Hasta la mitad de las distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, trauma, liquen). Antes de un tratamiento oral prolongado (terbinafina por 12 semanas en pies), con costo y riesgo hepático, se confirma la onicomicosis con examen directo con KOH y cultivo micológico, que además identifica el agente: dermatofito, levadura o moho.

## 1.04.4.004 Detección de antígeno de Cryptococcus en LCR y test de tinta china

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: meningitis subaguda en VIH avanzado (CD4 <100) con cefalea progresiva, fiebre baja, vómitos y escasa o nula rigidez de nuca.
- LCR típico: presión de apertura muy elevada (>30 cm H2O), pocas células linfocitarias, glucosa baja y proteínas levemente altas.
- Antígeno criptocócico (CrAg) en LCR o sangre: sensibilidad y especificidad >95 %; es el examen de elección para confirmar.
- Tinta china: levaduras con halo (cápsula); clásica pero menos sensible (alrededor de 70–80 %), un resultado negativo no descarta.
- Positivo: inducción con anfotericina B liposomal + flucitosina por 2 semanas, luego fluconazol, y punciones evacuadoras si la presión está alta; derivar.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 38 años con VIH sin tratamiento y CD4 de 40 células/mm³ presenta cefalea progresiva de 2 semanas, fiebre baja y vómitos, sin signos focales. La TAC de encéfalo es normal. La punción lumbar muestra presión de apertura de 35 cmH2O, 20 células/mm³ de predominio linfocitario, glucosa baja y proteínas levemente elevadas. **¿Cuál es el examen más sensible y específico para confirmar el diagnóstico más probable?**

**A)** Antígeno de Cryptococcus en LCR
**B)** Tinta china en LCR
**C)** Gram de LCR
**D)** ADA en LCR
**E)** Cultivo de Koch

Respuesta A. Meningitis subaguda con hipertensión intracraneana en VIH con CD4 bajo 100 sugiere criptococosis. El antígeno criptocócico en LCR (o suero) tiene sensibilidad y especificidad sobre 95%, superior a la tinta china (sensibilidad cercana a 70-80%). Se trata con anfotericina B más flucitosina y punciones evacuadoras si la presión está elevada.

## 1.04.4.005 Detección de agentes virales por inmunofluorescencia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Inmunofluorescencia de aspirado o hisopado nasofaríngeo: identifica en horas VRS, influenza A y B, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus.
- Utilidad principal en hospitalizados: aislar y cohortar pacientes, aplicar precauciones de contacto o gotitas y vigilancia epidemiológica; si muestra influenza, orienta a oseltamivir.
- La bronquiolitis y otras infecciones respiratorias virales son diagnóstico clínico: el examen no define gravedad ni justifica antibióticos o corticoides.
- Es menos sensible que la PCR (panel molecular); un resultado negativo con clínica sugerente no descarta la infección.
- Requiere una buena muestra con células epiteliales, tomada en los primeros días de síntomas.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un lactante de 4 meses es hospitalizado en julio por bronquiolitis con requerimiento de oxígeno. Se solicita panel viral por inmunofluorescencia en aspirado nasofaríngeo. **¿Cuál es la principal utilidad de este examen en este paciente?**

**A)** Decidir el uso de antibióticos de rutina
**B)** Identificar el virus (VRS, influenza, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus) para aislar y cohortar pacientes, y para vigilancia epidemiológica
**C)** Confirmar el diagnóstico de bronquiolitis, que no puede hacerse sin él
**D)** Indicar corticoides
**E)** Evaluar la gravedad del cuadro

Respuesta B. La bronquiolitis es un diagnóstico clínico. En hospitalizados, la inmunofluorescencia del aspirado nasofaríngeo identifica el virus en horas, lo que permite cohortar pacientes, aplicar precauciones de contacto o gotitas y hacer vigilancia epidemiológica; si muestra influenza, orienta a oseltamivir. No define la gravedad ni justifica antibióticos o corticoides.

## 1.04.4.006 Estudio citoquímico de LCR

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

### QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales: presión de apertura 10–20 cm H2O, <5 leucocitos/mm³, glucosa LCR/suero >0,6 y proteínas <45 mg/dL.
- Bacteriana: presión >25, 1.000–10.000 leucocitos con >80 % PMN, glucosa <0,4 y proteínas 100–500 mg/dL.
- Viral (aséptica): 50–500 células mononucleares, glucosa normal y proteínas 50–100 mg/dL; el agente más frecuente es enterovirus.
- Tuberculosa o fúngica: presión >30, 100–500 linfocitos, glucosa muy baja (<0,3) y proteínas muy altas. Encefalitis herpética: patrón viral con eritrocitos o xantocromía.
- La glucosa es el dato que más discrimina; interpretar siempre con la glicemia simultánea y completar con Gram, cultivo, PCR o antígenos según la sospecha.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 30 años con 5 días de cefalea, fiebre de 38 °C y rigidez de nuca, sin compromiso de conciencia ni focalidad. LCR: claro, 180 células/mm³ con 90 % de linfocitos, proteínas 0,7 g/L, glucosa 60 mg/dL con glicemia de 100 mg/dL, y Gram sin bacterias. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

**A)** Enterovirus
**B)** Streptococcus pneumoniae
**C)** Mycobacterium tuberculosis
**D)** Listeria monocytogenes
**E)** Neisseria meningitidis

Respuesta A. LCR claro con pleocitosis linfocitaria moderada, proteínas levemente elevadas y glucosa normal (índice LCR/plasma 0,6) es un patrón de meningitis viral, y el agente más frecuente es enterovirus. La bacteriana da neutrófilos y glucosa baja; la tuberculosa, linfocitos con glucosa muy baja y proteínas muy altas.

## 1.04.4.007 Cultivo de expectoración

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: neumonía grave u hospitalizada, mala respuesta al tratamiento, sospecha de gérmenes resistentes, bronquiectasias o fibrosis quística, y estudio de TBC (baciloscopía y cultivo de Koch).
- Calidad de la muestra: expectoración profunda (no saliva), con >25 leucocitos y <10 células epiteliales por campo; el Gram valida la muestra y orienta (diplococos Gram positivos lanceolados: neumococo; cocos en racimos: estafilococo).
- Enviar rápido al laboratorio, idealmente antes del antibiótico. Su rendimiento es bajo en la neumonía comunitaria ambulatoria, donde no se pide de rutina.

- TBC: 2 muestras (una inmediata y otra matinal al día siguiente) para baciloscopía, GeneXpert y cultivo de Koch (Löwenstein-Jensen o MGIT), que es el estándar de oro y el único que da antibiograma completo.
- Interpretar en contexto: flora orofaríngea mixta suele ser contaminación; un cultivo de Koch positivo confirma TBC activa aunque la baciloscopía sea negativa.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 17**
>
> Un paciente presenta 2 meses de malestar general, tos con expectoración, sensación febril, baja de peso y sudoración. En el último tiempo ha aumentado la tos y ha presentado expectoración hemoptoica. El hemograma muestra leucocitosis de 15.000/mm³ y la radiografía de tórax AP muestra compromiso de ambos lóbulos superiores, mayor al lado izquierdo, con una banda atelectásica en el ápice izquierdo. **¿Cuál es el examen más adecuado ante la sospecha diagnóstica?**
>
> **A)** Broncoscopía
> **B)** Baciloscopías de expectoración más cultivo de Koch
> **C)** TAC de tórax
> **D)** Cultivo de expectoración
> **E)** Hemocultivos
>
> Respuesta B. Tos productiva prolongada, baja de peso, sudoración, hemoptisis y compromiso de lóbulos superiores sugieren tuberculosis pulmonar. Se estudia en expectoración con baciloscopías (o PCR para TBC, cada vez más usada como examen inicial) más cultivo de Koch. El cultivo corriente de expectoración no detecta Mycobacterium tuberculosis.

## 1.04.4.008 Gram

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

**QUÉ HAY QUE SABER**

- El Gram clasifica bacterias según su pared y forma en minutos; orienta la terapia empírica antes del cultivo.
- Cocos Gram positivos en racimos: estafilococos (S. aureus); en cadenas: estreptococos; diplococos lanceolados: neumococo; en pares o cadenas cortas: enterococo.
- Diplococos Gram negativos: Neisseria (intracelulares en PMN en uretritis = gonococo; en LCR = meningococo). Bacilos Gram positivos: Listeria, Clostridium, B. anthracis (caña de bambú). Bacilos Gram negativos: enterobacterias, Pseudomonas, Haemophilus.
- Ver PMN sin bacterias orienta a gérmenes que no se tiñen (Chlamydia, Mycoplasma, Legionella) o a tratamiento antibiótico previo; las micobacterias requieren Ziehl-Neelsen.
- En expectoración la muestra es válida si tiene >25 PMN y <10 células epiteliales por campo de menor aumento.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 135**
>
> En el examen microscópico de una muestra de esputo se observan cocos grampositivos agrupados en racimos. **¿A qué bacteria corresponde este patrón morfológico?**
>
> **A)** Staphylococcus aureus
> **B)** Streptococcus pneumoniae
> **C)** Enterococcus faecalis
> **D)** Listeria monocytogenes
> **E)** Neisseria meningitidis
>
> Respuesta A. Los cocos grampositivos en racimos corresponden a estafilococos, como S. aureus, causa de neumonía post influenza, nosocomial y necrotizante. S. pneumoniae se ve como diplococos grampositivos lanceolados, Enterococcus en pares o cadenas cortas, Listeria como bacilos grampositivos y Neisseria como diplococos gramnegativos.

## 1.04.4.009 Hemocultivo

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: fiebre con sospecha de bacteriemia, sepsis, endocarditis, infección de catéter, meningitis o neumonía grave.

- Técnica: al menos 2 sets por punciones de sitios distintos, antes del antibiótico pero sin retrasarlo (en shock séptico, dentro de la primera hora); no es necesario esperar el peak febril.
- Un solo set dificulta distinguir contaminantes; S. epidermidis en un solo frasco suele ser contaminación, mientras S. aureus siempre es significativo.
- Sospecha de infección de catéter: hemocultivos pareados (periférico y de cada lumen); el CVC positivo >2 h antes que el periférico apunta al catéter.
- S. aureus o Candida en hemocultivos obligan a buscar foco y complicaciones: ecocardiograma (endocarditis) y fondo de ojo (endoftalmitis por Candida).

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 70 años llega a urgencia con fiebre de 39 °C, confusión, PA 85/50 mmHg, FC 120 por minuto y lactato de 4 mmol/L. Se sospecha shock séptico de foco urinario. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de los hemocultivos?**

**A)** Iniciar antibióticos y tomar hemocultivos al día siguiente si persiste la fiebre
**B)** Esperar el peak febril para tomar los hemocultivos
**C)** Tomar 1 solo hemocultivo para ahorrar recursos
**D)** Tomar 2 sets de hemocultivos de sitios distintos antes del antibiótico, sin retrasar su inicio más allá de la primera hora
**E)** Tomar los hemocultivos desde la sonda urinaria

Respuesta D. En sepsis se toman al menos 2 sets de hemocultivos por punciones separadas antes del antibiótico, pero sin retrasarlo: en shock séptico debe darse dentro de la primera hora. No es necesario esperar el peak febril, y tomarlos tras el antibiótico reduce su rendimiento. Un solo set dificulta distinguir contaminantes.

## 1.04.4.010 Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS)

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda orienta a infección bacteriana; la leucopenia con neutropenia aparece en tifoidea (hemograma tífico, con aneosinofilia), virosis, sepsis grave o quimioterapia.
- Linfocitosis con más de 10 % de linfocitos atípicos: mononucleosis por VEB (también CMV, toxoplasma, VIH agudo). Eosinofilia marcada: parasitosis tisulares (triquinosis), alergia o fármacos.
- Neutropenia febril: calcular el RAN = leucocitos × (% segmentados + % baciliformes)/100; <500 define riesgo. Hanta: plaquetas <100.000, hematocrito alto e inmunoblastos >10 %.
- VHS: marcador inespecífico de inflamación, sube lento y baja lento; muy alta (>100 mm/h) en osteomielitis, endocarditis, TBC, arteritis de células gigantes, mieloma o neoplasias; útil en el seguimiento de osteomielitis.
- Ninguno de los dos es diagnóstico por sí solo: interpretarlos con la clínica y repetir para evaluar la evolución.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un estudiante de 18 años presenta, desde hace 1 semana, fiebre, odinofagia intensa con exudado amigdalino, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia leve. **¿Qué hallazgo del hemograma es más característico del diagnóstico más probable?**

**A)** Neutrofilia con desviación a izquierda
**B)** Policitemia
**C)** Eosinofilia marcada
**D)** Pancitopenia con blastos
**E)** Linfocitosis con más de 10% de linfocitos atípicos (reactivos)

Respuesta E. Fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia en un adolescente sugieren mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. El hemograma muestra linfocitosis con más de 10% de linfocitos atípicos y suele haber alza leve de transaminasas. Se confirma con anticuerpos heterófilos o IgM anti-VCA. La neutrofilia orientaría a infección bacteriana.

## 1.04.4.011 Parasitológico de deposiciones

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: diarrea prolongada o crónica, esteatorrea, dolor abdominal recurrente, eosinofilia o contactos con parasitosis; no se pide en la diarrea aguda habitual.
- Técnica: parasitológico seriado con 3 muestras en días distintos en frasco con fijador, porque la eliminación de quistes y huevos es intermitente.
- Hallazgos frecuentes: quistes de Giardia lamblia (tratar con tinidazol o metronidazol), Blastocystis, Entamoeba histolytica, huevos de Trichuris o Ascaris.
- El test de Graham (cinta adhesiva perianal matinal) es el examen para Enterobius vermicularis ante prurito anal; el parasitológico habitual no lo detecta.
- En inmunosuprimidos (VIH con CD4 <100) pedir tinción de Ziehl-Neelsen modificada para Cryptosporidium, Cystoisospora y Cyclospora, que no se ven en el examen habitual.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 5 años, que asiste a jardín infantil, presenta deposiciones blandas, malolientes y esteatorreicas, distensión abdominal y baja de peso de 6 semanas de evolución. **¿Cuál es el examen más adecuado para el diagnóstico etiológico más probable?**
>
> **A)** Coprocultivo
> **B)** Test de Graham
> **C)** Examen parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días distintos)
> **D)** Colonoscopía
> **E)** Antígeno de rotavirus en deposiciones
>
> Respuesta C. Diarrea crónica esteatorreica con distensión y baja de peso en un preescolar de jardín infantil sugiere giardiasis. El parasitológico seriado (3 muestras en días alternos, con fijador) mejora la sensibilidad porque la eliminación de quistes es intermitente. El test de Graham busca Enterobius ante prurito anal. Se trata con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida.

## 1.04.4.012 Proteína C reactiva

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.16 Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Reactante de fase aguda hepático que sube en 6–8 h y peaks a las 48 h; más rápida y sensible que la VHS para evaluar inflamación aguda y su evolución.
- Valores muy altos sugieren infección bacteriana (neumonía, pielonefritis, abscesos, sepsis), aunque también sube en trauma, cirugía, pancreatitis y enfermedades inflamatorias.
- Postoperatorio: sube tras toda cirugía con peak a las 48 h y luego baja; si sigue subiendo entre el 3.er y 5.º día sugiere complicación infecciosa (filtración anastomótica, absceso, infección de herida) y obliga a estudiar con TAC.
- Útil para seguimiento: el descenso indica buena respuesta al tratamiento; un ascenso persistente sugiere falla, absceso o foco no controlado.
- Inespecífica: no distingue por sí sola etiología bacteriana de viral ni reemplaza los cultivos; interpretar con la clínica.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 60 años cursa su 4° día postoperatorio de una resección de colon con anastomosis. Su PCR fue de 140 mg/L al 2° día y hoy sube a 290 mg/L, con febrícula y taquicardia de 110 por minuto. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

**A)** Es la respuesta inflamatoria normal a la cirugía y no requiere estudio
**B)** La PCR solo sirve en infecciones virales
**C)** Una PCR en ascenso después del 3er día sugiere una complicación infecciosa, como filtración anastomótica, y obliga a estudiar (ej. TAC de abdomen)
**D)** Indica con certeza un tromboembolismo pulmonar
**E)** Se debe a la anestesia

Respuesta C. La PCR sube tras cualquier cirugía, con un máximo cercano a las 48 horas, y luego desciende. Si en vez de bajar sigue subiendo entre el 3° y 5° día, sugiere una complicación infecciosa (filtración anastomótica, absceso, infección de herida) y obliga a estudiar, habitualmente con TAC de abdomen y pelvis con contraste.

## 1.04.4.014 Pruebas rápidas para diagnóstico de estreptococo grupo A

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

### QUÉ HAY QUE SABER

- Test rápido de antígeno de S. pyogenes en hisopado faríngeo: indicado en faringoamigdalitis con McIsaac de 2 a 3 puntos (fiebre, exudado, adenopatías anteriores dolorosas, ausencia de tos, edad 3–14 años); con 0–1 no se estudia.
- Especificidad alta (cerca de 95 %): un resultado positivo permite tratar con penicilina benzatina o amoxicilina por 10 días.
- Sensibilidad 70–90 %: en niños con clínica sugerente, un negativo se confirma con cultivo faríngeo (estándar de oro); en adultos no suele ser necesario.
- No pedir si hay síntomas virales (tos, coriza, conjuntivitis, aftas); la ASO no sirve en el cuadro agudo.
- El objetivo del diagnóstico y del tratamiento es prevenir la fiebre reumática y las complicaciones supuradas.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una niña de 7 años presenta fiebre de 38,8 °C, odinofagia, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas, sin tos ni coriza. El test rápido de antígeno para estreptococo grupo A resulta negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Iniciar amoxicilina de todas formas
**B)** Solicitar cultivo faríngeo, por la sensibilidad imperfecta del test rápido en niños
**C)** Descartar definitivamente la etiología estreptocócica
**D)** Indicar azitromicina
**E)** Solicitar ASO

Respuesta B. El test rápido tiene alta especificidad (cerca de 95%), por lo que un positivo permite tratar, pero su sensibilidad es menor (70-90%). En niños, con alta prevalencia de estreptococo y riesgo de fiebre reumática, un negativo con clínica sugerente se confirma con cultivo faríngeo; en adultos no suele ser necesario. La ASO no sirve en el cuadro agudo.

## 1.04.4.015 Reacción de polimerasa en cadena

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- PCR (reacción de polimerasa en cadena): amplifica ADN o ARN del agente; alta sensibilidad y especificidad, resultado en horas y útil aun con antibiótico previo.
- GeneXpert MTB/RIF: examen inicial de elección en TBC; detecta M. tuberculosis y resistencia a rifampicina (gen rpoB) en menos de 2 h. Prueba inicial preferente en niños, VIH, contactos de resistentes y personal de salud.
- Otras aplicaciones: PCR de VHS en LCR (encefalitis herpética, sensibilidad >95 %), carga viral de VIH y CMV, SARS-CoV-2, paneles respiratorios, PCR de toxina de C. difficile y Chlamydia o gonococo en orina.

- Una PCR positiva detecta material genético pero no siempre infección activa (puede persistir tras la curación); interpretar con la clínica.
- No reemplaza el cultivo cuando se necesita antibiograma completo (por ejemplo el cultivo de Koch en TBC).

**PREGUNTAS (2)**

> **Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 26**
>
> Un paciente de 39 años, VIH positivo, que abandonó el tratamiento antiviral hace varios meses, consulta por un cuadro de tos de 2 meses de evolución, asociado a expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica, más sensación febril y baja de peso de 3 kilogramos. Al examen físico, se aprecia enflaquecido, con FC: 100x', PA: 110/60 mmHg, FR: 22x', saturación de oxígeno: 93%, Tº: 37,5ºC y, en el examen pulmonar, se auscultan crepitaciones y estertores bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que se muestra zonas de relleno bilaterales y se solicitan baciloscopías de expectoración que resultan negativas, con muestra hemorrágica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Solicitar TAC de tórax
> **B)** Realizar lavado bronquioalveolear
> **C)** Realizar broncoscopía
> **D)** Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
> **E)** Iniciar tratamiento con ceftriaxona endovenosa
>
> Respuesta D. Clínica de tuberculosis en un paciente con VIH, con baciloscopías negativas en una muestra hemorrágica. La baciloscopía es poco sensible; la PCR (GeneXpert) es más sensible y es la prueba de elección en personas con VIH.

> **Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 149**
>
> Un paciente de 35 años, en situación de calle, presenta un cuadro de 6 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido, pálido, con T°: 37,5°C, FC: 87x', PA: 110/70 mmHg, FR: 18x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales y algunas sibilancias. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.600 por mm3, VHS: 60 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo, PCR covid-19 negativa, baciloscopías de expectoración negativas, con muestra hemorrágica y PPD: 20mm. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente radiopaedia): **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Solicitar TAC de tórax
> **B)** Solicitar cultivo para bacillus tuberculosis en medio sólido
> **C)** Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
> **D)** Repetir la PCR de covid-19 en muestra nasofaríngea
> **E)** Realizar fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
>
> Respuesta C. Clínica de tuberculosis con baciloscopías negativas: la PCR para tuberculosis (GeneXpert) es más sensible, da resultado rápido y hoy es el examen inicial de elección. El cultivo también sirve, pero tarda semanas.

## 1.04.4.016 Serología de enfermedades infecciosas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas · Tema 4.2 Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Detecta anticuerpos contra el agente: IgM indica infección reciente; IgG, infección pasada o inmunidad (salvo seroconversión o alza de títulos en muestras pareadas).
- Sífilis: VDRL o RPR cuantitativo mide actividad (curación = caída de 4 veces en 6–12 meses); treponémica (FTA-ABS, MHA-TP) confirma y queda positiva de por vida. VDRL bajo con treponémica negativa = falso positivo biológico (LES, embarazo).
- VIH: ELISA de 4.ª generación o test rápido como tamizaje (alta sensibilidad); un resultado reactivo se confirma en el ISP. Considerar el período de ventana.
- Chagas crónico: IgG por dos técnicas (ELISA + IFI o HAI); en el recién nacido la IgG refleja anticuerpos maternos y se usa microhematocrito o PCR. Otras: hidatidosis (apoyo de la imagen), hantavirus (IgM), VEB (IgM VCA), leptospirosis (MAT).
- El test de Widal no confirma fiebre tifoidea; en inmunosuprimidos la serología puede ser falsamente negativa.

**PREGUNTAS (3)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 122**

Una paciente se realiza exámenes porque su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene AgHBs negativo y anticuerpos anti-HBs (antisuperficie) positivos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Vacunada contra la hepatitis B
**B)** Hepatitis B aguda
**C)** Hepatitis B crónica
**D)** Hepatitis B en período de ventana
**E)** Infección asintomática por virus hepatitis B

Respuesta A. AgHBs negativo descarta infección activa y anti-HBs positivo indica inmunidad. Sin anti-HBc informados, el anti-HBs aislado corresponde a inmunidad por vacuna (una infección resuelta tendría anti-HBc IgG positivo). No hay enfermedad activa ni período de ventana.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 2**

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde la FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL, que resulta "no reactivo" y un MHA-TP, que resulta "reactivo". **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Administrar penicilina benzatina de inmediato
**B)** Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo
**C)** Controlar con VDRL a las 30 semanas
**D)** Solicitar un FTA-ABS
**E)** Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta C. VDRL no reactivo con treponémica (MHA-TP) reactiva: cicatriz serológica de una sífilis tratada. No hay actividad, así que no se trata; se sigue el control prenatal habitual, con el VDRL que corresponde a las 28–30 semanas.

**Pregunta de práctica**

Recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional, hijo de madre de 28 años con Chagas crónico asintomático confirmado en el control prenatal. Nace vigoroso, afebril, sin visceromegalias ni alteraciones al examen físico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Solicitar serología IgG anti-T. cruzi al recién nacido
**B)** Microhematocrito (o PCR) al nacer
**C)** Iniciar nifurtimox de inmediato sin estudio
**D)** Alta sin estudio, porque el examen físico es normal
**E)** Electrocardiograma y ecocardiograma neonatal

Respuesta B. En el RN hijo de madre con Chagas se hace de inmediato un parasitológico directo (microhematocrito en sangre de cordón o periférica, o PCR). La IgG refleja los anticuerpos maternos transferidos por la placenta. Si es positivo, se trata (curación > 95 %); si es negativo, se repite a los 3 meses o se pide IgG después de los 9–12 meses.

## 1.04.4.017 Urocultivo y antibiograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado para confirmar ITU sintomática, en ITU febril o complicada, en niños, embarazadas (tamizaje de bacteriuria asintomática) y antes de procedimientos urológicos; la tira reactiva solo orienta.
- Muestra: segundo chorro con aseo genital; en niños sin control de esfínter, cateterismo vesical o punción suprapúbica. La bolsa recolectora tiene muchos falsos positivos y solo vale si es negativa.
- Interpretación: ≥100.000 UFC/mL en segundo chorro; recuentos menores son significativos por sondeo (habitualmente ≥10.000) y cualquier recuento por punción suprapúbica; varios gérmenes sugieren contaminación.
- Si no se siembra dentro de 2 h, refrigerar a 4 °C. El antibiograma permite ajustar el antibiótico empírico.
- No pedir urocultivos de rutina ni tratar la bacteriuria asintomática, salvo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos; la piuria con urocultivo negativo obliga a pensar en TBC urinaria o uretritis.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una lactante de 8 meses, sin control de esfínter, presenta fiebre de 39 °C sin foco de 2 días de evolución. Se sospecha infección urinaria. **¿Cuál es el método más adecuado para obtener la muestra de urocultivo?**

**A)** Bolsa recolectora adhesiva
**B)** No es necesario urocultivo si la tira reactiva es positiva
**C)** Muestra obtenida del pañal
**D)** Orina de segundo chorro espontánea
**E)** Cateterismo vesical (sondeo) con técnica estéril

Respuesta E. En niños sin control de esfínter, el urocultivo se toma por cateterismo vesical (o punción suprapúbica) con técnica estéril. La bolsa recolectora tiene alta tasa de contaminación y falsos positivos; solo es útil si resulta negativa. El urocultivo es indispensable para confirmar la ITU y guiar el antibiótico; la tira reactiva solo orienta.

## Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 4 códigos

### 1.04.5.001 Drenaje de abscesos superficiales

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: colección fluctuante (absceso, forúnculo grande, adenoflegmón); el antibiótico solo no resuelve una colección.
- Técnica: asepsia y anestesia local, incisión amplia sobre la zona de mayor fluctuación siguiendo líneas de tensión, ruptura de tabiques, lavado con suero, dejar abierto o con mecha y curaciones posteriores.
- Enviar el pus a Gram y cultivo, sobre todo si hay recurrencia o sospecha de SAMR.
- Antibiótico solo si hay celulitis extensa, compromiso sistémico, inmunosupresión o diabetes, o ubicación de riesgo (cara, mano, perineal).
- Derivar a cirugía: abscesos profundos, perianales complejos, de mano o cara, carbunco estafilocócico extenso o sospecha de fascitis necrotizante.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 30 años presenta un absceso de 3 cm en el muslo, fluctuante, con eritema alrededor de 1 cm, sin fiebre ni compromiso sistémico. No es diabético ni inmunosuprimido. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Antibiótico oral solamente por 10 días
**B)** Punción con aguja fina sin drenaje
**C)** Compresas frías y observación
**D)** Incisión y drenaje bajo anestesia local, con lavado de la cavidad
**E)** Hospitalizar para antibiótico endovenoso

Respuesta D. El tratamiento fundamental de un absceso cutáneo fluctuante es la incisión y drenaje: incisión amplia sobre la zona de mayor fluctuación, ruptura de tabiques, lavado con suero y curaciones. Sin celulitis extensa, compromiso sistémico ni inmunosupresión, el antibiótico no es indispensable; sin drenaje, el antibiótico solo no resuelve la colección.

### 1.04.5.002 Punción lumbar

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: sospecha de meningitis o encefalitis; también hemorragia subaracnoidea con TAC normal y otras patologías neurológicas.
- TAC previa obligatoria si hay déficit focal, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión (riesgo de herniación); en meningitis no retrasar hemocultivos, dexametasona ni antibióticos por la imagen.
- Contraindicaciones: masa o efecto de masa intracraneano, absceso cerebral, infección en el sitio de punción y coagulopatía o trombocitopenia importante.
- Técnica: decúbito lateral en flexión (o sentado), espacio L3-L4 o L4-L5 (línea entre crestas ilíacas), asepsia, medir la presión de apertura y recolectar tubos para citoquímico, Gram, cultivo y PCR o antígenos.

- Complicación más frecuente: cefalea post punción (mejora en decúbito); la más grave, herniación.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 70 años con fiebre de 39 °C, cefalea y rigidez de nuca, que además presenta una crisis convulsiva y hemiparesia derecha. Glasgow 12. **Respecto de la punción lumbar, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Punción lumbar inmediata y antibióticos según el Gram
> **B)** Hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos, y luego TAC de cerebro antes de la punción lumbar
> **C)** TAC de cerebro y esperar su resultado para iniciar antibióticos
> **D)** Contraindicar definitivamente la punción lumbar
> **E)** Punción lumbar con la paciente sentada, sin imágenes previas
>
> Respuesta B. Focalidad neurológica, convulsiones, compromiso de conciencia, inmunosupresión o papiledema obligan a TAC antes de la punción por riesgo de herniación. Pero el antibiótico no se retrasa: hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos primero; luego TAC y, si no hay efecto de masa, punción lumbar.

## 1.04.5.003 Sembrar muestras para cultivo

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Tomar las muestras antes del antibiótico siempre que no retrase el tratamiento, con técnica aséptica y en recipiente estéril rotulado.
- Hemocultivos: 2 sets por punciones separadas, con desinfección de la piel y del tapón del frasco.
- LCR para cultivo: no refrigerar (meningococo y Haemophilus son lábiles al frío); enviar de inmediato a temperatura ambiente o mantener en estufa a 35–37 °C.
- Orina: segundo chorro o sondeo; si no se siembra dentro de 2 h, refrigerar a 4 °C para evitar la multiplicación bacteriana.
- Heridas y abscesos: preferir aspirado del pus o tejido profundo antes que tórulas superficiales, que se contaminan con flora de la piel.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
>
> Se realiza una punción lumbar a las 3 de la madrugada a un paciente de 25 años con sospecha de meningitis bacteriana. El laboratorio de microbiología procesará la muestra en 2 horas. **¿Cuál es el manejo más adecuado de la muestra de LCR para cultivo?**
>
> **A)** Mantenerla a temperatura ambiente (o en estufa a 35-37 °C) y enviarla lo antes posible
> **B)** Refrigerarla a 4 °C hasta su procesamiento
> **C)** Congelarla
> **D)** Agregarle suero fisiológico para conservarla
> **E)** Sembrarla al día siguiente
>
> Respuesta A. El LCR para cultivo no se refrigera, porque N. meningitidis y H. influenzae son lábiles al frío. Se envía de inmediato a temperatura ambiente o se mantiene en estufa a 35-37 °C. En cambio, la orina para urocultivo sí se refrigera si no se siembra dentro de 2 horas, para evitar la multiplicación bacteriana.

## 1.04.5.004 Tinción de Gram

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicaciones: secreción uretral, LCR, expectoración, pus o líquidos estériles; permite orientar el tratamiento en minutos.
- Técnica: frotis delgado secado y fijado con calor; cristal violeta, lugol, decoloración con alcohol-acetona y safranina; los Gram positivos quedan morados y los Gram negativos rosados.
- Uretritis en hombre sintomático: diplococos Gram negativos intracelulares en PMN confirman gonococo (sensibilidad >95 %); PMN sin bacterias = uretritis no gonocócica (Chlamydia).

- Errores habituales: frotis muy grueso, decoloración excesiva (falsos Gram negativos) o insuficiente, y muestras tomadas tras el antibiótico.
- Toda uretritis se trata con doble cobertura aunque el Gram muestre solo gonococo (ceftriaxona + doxiciclina).

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
>
> Un hombre de 25 años consulta por secreción uretral purulenta abundante y disuria de 3 días, tras una relación sexual sin preservativo. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral. **¿Qué hallazgo confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica?**
>
> **A)** Cocos grampositivos en racimos
> **B)** Bacilos grampositivos
> **C)** Diplococos gramnegativos intracelulares dentro de polimorfonucleares
> **D)** Levaduras con pseudohifas
> **E)** Ausencia de leucocitos
>
> Respuesta C. En hombres con uretritis sintomática, el Gram de la secreción con diplococos gramnegativos intracelulares en polimorfonucleares tiene alta sensibilidad y especificidad para gonorrea. Leucocitos sin diplococos indican uretritis no gonocócica (Chlamydia, Mycoplasma). Se trata con ceftriaxona más cobertura de Chlamydia, como doxiciclina.